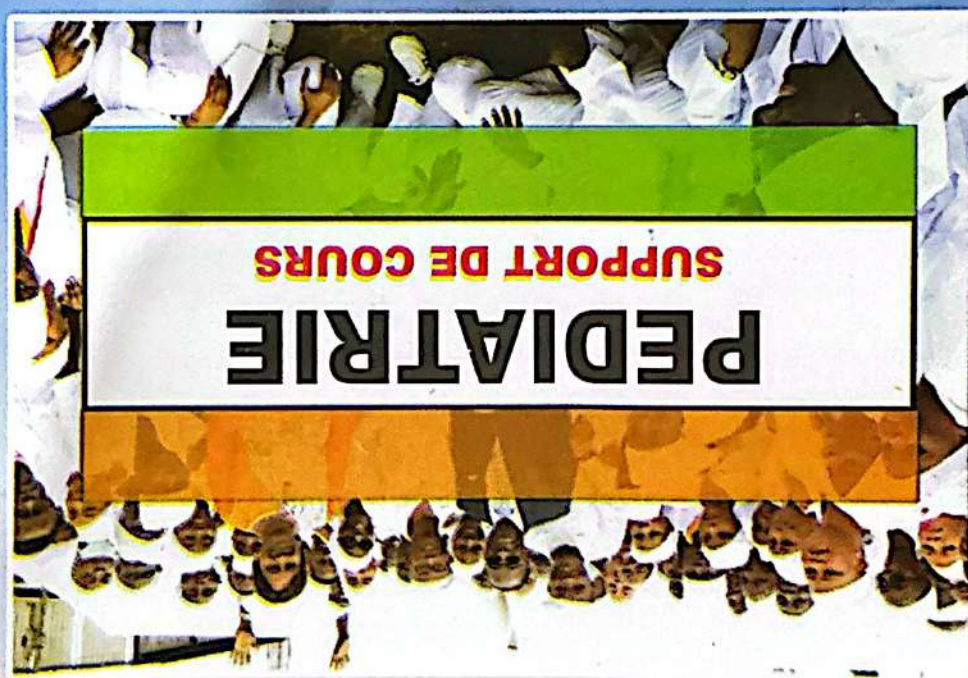


INFIRMIERS(ÈRES), SAGES - FEMMES, MAÏEUTICIENS



UNITÉ PÉDAGOGIQUE DE PÉDIATRIE



Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique
et de la Couverture Maladie Universelle



République de Côte d'Ivoire



Union - Discipline - Travail

Ont collaboré à la réalisation de ce document

Professeur ASSE Kouadio Vincent, Professeur des Universités, Chef de service de pédiatrie du CHU de Bouaké ; Chef de file de la cellule pédagogique de pédiatrie

Professeur OULAÏ Soumahoro, Professeur émérite des Universités ;

Professeur AZAGOH-KOUADIO Richard, Professeur des Universités, Chef de service de pédiatrie du CHU de Angré ;

Dr CISSE Lacina, Maître de Conférences Agrégé en Pédiatrie à l'Université Félix Houphouët BOIGNY d'Abidjan ;

Dr YAO Atteby Jean-Jacques, Maître de Conférences Agrégé en Pédiatrie à l'Université Félix Houphouët BOIGNY d'Abidjan ;

Dr YENAN John Patrick, Maître de Conférences Agrégé en Pédiatrie au CHU de Bouaké ;

Dr YEBOUA Kossonou Roland, Maître de Conférences Agrégé en Pédiatrie au CHU de Bouaké ;

Dr YAO Kouassi Christian, Maître de Conférences Agrégé en Pédiatrie au CHU de Bouaké ;

Dr AKA-TANOH Aude-Hélène, Maître-assistant, Service de pédiatrie CHU Bouaké

Dr AVI-SIALLOU Christelle, Maître-assistant, Service de pédiatrie CHU Bouaké ;

INTRODUCTION

L'enseignement magistral de la pédiatrie à l'école de base de l'Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS) durant la première année est consacrée essentiellement à l'enfant normal. Les dix leçons du programme abordés durant cette année académique sont listés ci-après :

1. Généralités sur la pédiatrie
2. Nouveau-né normal
3. Examen du nouveau-né en salle de naissance
4. Nouveau-né prématuré
5. Allaitement
6. Croissance
7. Développement psychomoteur
8. Vomissements
9. Diarrhée aiguë et déshydratation
10. Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant

Le présent support de cours est organisé en trois parties. La première partie résume l'essentiel des informations délivrées au cours magistral et la seconde indique à l'apprenant les directives à suivre pour le travail personnel afin de maîtriser le contenu des différentes leçons abordées. Quant à la troisième partie, elle est consacrée aux exercices d'application. Ce document, fruit de la réflexion des enseignants universitaires de la cellule pédagogique de pédiatrie se veut perfectible et pourra être révisé avec l'usage.

1^{ère} PARTIE LEÇONS

GENERALITES SUR LA PEDIATRIE

Objectif institutionnel

Former des agents de santé 5 étoiles capable de:

- conseiller les parents,
- assurer des soins préventifs
- assurer des soins curatifs
- participer à la gestion d'un service de pédiatrie
- Participer au développement de la communauté

Objectif général

1. Connaître les aspects importants de la pédiatrie en Côte d'Ivoire

Objectifs spécifiques

1. Définir les termes : pédiatrie, néonatalogie, nouveau-né, nourrisson, enfant préscolaire, enfant, adolescent
2. Décrire les besoins de l'enfant
3. Citer les principales maladies de l'enfant
4. Décrire le rôle des acteurs à travers le triangle pédiatrique

Plan

Introduction

- I. Aspects démographiques et Besoins de l'enfant
- II. Principales maladies de l'enfant
- III. Acteurs et rôles
- IV. Méthodes, stratégies d'apprentissage et supports pédagogiques
- V. Méthodes d'évaluation de l'enseignement

Conclusion

INTRODUCTION**1. Définitions****• Pédiatrie**

Branche spécialisée de la médecine consacrée à l'enfant

- Développement
- Physiologie normale
- Maladies infantiles

• Néonatalogie

Branche spécialisée de la pédiatrie consacrée au fœtus et au nouveau-né

- Développement
- Physiologie normale
- Maladies infantiles

• Groupes d'enfants

- Nouveau-né (0 - 28 jours). Trait caractéristique du groupe : fragilité
- Nourrisson (1 - 23 mois). Trait caractéristique du groupe : alimentation
- Enfant préscolaire (2- 5 ans). Trait caractéristique du groupe : jeux
- Enfant (6-12 ans). Trait caractéristique du groupe : apprentissage
- Adolescent (13-18 ans). Trait caractéristique du groupe : conflit avec la société

2. Intérêt

La pédiatrie est une discipline importante enseignée à l'INFAS. Elle fait partie des disciplines retenues pour l'évaluation au diplôme d'état. Le cours « Généralités sur la pédiatrie » présente les aspects importants de la pédiatrie en Afrique subsaharienne particulièrement en Côte d'Ivoire. Il met l'accent sur les aspects pédiatriques qui feront l'objet d'un développement ultérieur durant les trois années de formation.

I. ASPECTS DEMOGRAPHIQUES ET BESOINS DE L'ENFANT

La population de la côte d'ivoire était estimée en 2021 à 29 389 150 Habitants. Les enfants âgés de 0-14 ans représente 38% de la population. Le sex-ratio est de 1,04 (104/100). Les sujets âgés de 15-64 ans et 65 ans & plus représentaient respectivement 59% et 3%. Le taux de natalité est élevé 28,2 pour mille. La mortalité globale est de 9,5 pour mille. Le taux de mortalité infantile est très élevé 52 pour mille naissance vivante.

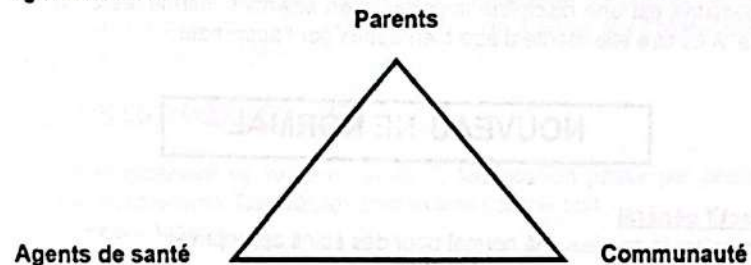
Les principaux besoins de l'enfant en bonne santé portent sur l'alimentation, le développement (croissance et développement psychomoteur), la protection et l'éducation

II. PRINCIPALES MALADIES INFANTILES

Groupes d'âges	Principales pathologies
Nouveau-né	Infection bactérienne, Prématurité, Détresse respiratoire, Asphyxie périnatale, Malformations
Nourrissons et enfants	Paludisme, Infections respiratoires aiguës, Gastroentérite, Malnutrition, Méningite, Anémie, Infection VIH/sida, Accidents, Cancer, Maladies génétiques
Adolescents	Paludisme, Pneumonie, Infection VIH/sida, Accidents, Drépanocytose, Cancer

III. ACTEURS ET ROLES

Les acteurs en pédiatrie sont les parents, la communauté, l'enfant et les agents de santé.

**IV. METHODES, STRATEGIES D'APPRENTISSAGE ET SUPPORT PEDAGOGIQUE**

Il existe plusieurs méthodes pour conduire l'enseignement en pédiatrie.

Nous utiliserons surtout :

- Enseignement magistral
- Brainstorming
- Enseignements dirigés

Ci-dessous les références des supports pédagogiques à avoir pour un bon apprentissage de la pédiatrie dans notre contexte.

REFERENCES

- **Asse KV, Kouadio-Gbokossou AO, Djeouhe A.** *Conseils et soins au nouveau-né.* EDUCI, Abidjan, 2018, ISBN 978-2-35565-061-1. 129p
- **Asse KV.** *L'essentiel en pédiatrie tropicale.* EDUCI, Abidjan, 2016, ISBN 978-2-35565-043-7. 491p
- **Asse KV, Koffi BP.** *Comment réussir l'épreuve de pédiatrie au diplôme d'état. A l'usage des étudiants des sciences infirmières.* EDUCI, Abidjan, 2016, ISBN 978-2-35565-048-2. 227p

V. METHODES D'EVALUATION DE L'ENSEIGNEMENT

L'évaluation de l'enseignement est formative et sommative. Les questions sont formulées sous plusieurs formes : QCM, QCD, QROC, Situations/ problèmes (=cas cliniques). L'admission est prononcée si au terme des différentes évaluation, la moyenne est $\geq$ à 10 sur 20

CONCLUSION

La pédiatrie est une discipline importante en sciences infirmières et de la santé. A ce titre elle mérite d'être bien appris par l'apprenant.

NOUVEAU-NE NORMAL

Objectif général

- Connaître le nouveau-né normal pour des soins appropriés

Objectifs spécifiques

1. Définir les termes : nouveau-né normal, bilan prénatal, Terme normal d'une grossesse
2. Citer les examens recommandés du bilan prénatal
3. Enumérer les prophylaxies de la gestante
4. Décrire les caractéristiques morphologiques et de maturation du nouveau-né normal
5. Lister les besoins du nouveau-né normal

Plan

Introduction

- I. Rappel physiologique
- II. Diagnostic

III. Besoins

IV. Soins du nouveau-né normal

Conclusion

INTRODUCTION

1. Définitions

- **Nouveau-né normal** : être vivant né avec une bonne vitalité au terme d'une grossesse dont le terme est normal et ne présentant ni malformation ni traumatisme
- **Bilan prénatal** : ensemble des examens biologiques et d'imagerie (échographie) réalisés au cours de la grossesse pour la surveillance de l'état de santé du fœtus et de la mère.
- **Terme normal** : le terme d'une grossesse est compris entre 37 et 41 Semaines + 6 jours d'aménorrhée.

2. Intérêt

Le nouveau-né normal représente 90% des naissances. La priorité de l'agent de santé en présence d'un nouveau-né normal porte sur l'alimentation ; l'hygiène et la surveillance.

I. RAPPELS PHYSIOLOGIQUES

Le développement de l'enfant depuis la fécondation passe par plusieurs étapes successives. Ces étapes sont listées comme suit :

- Fécondation
- Œuf
- Nidation (J8)
- Embryon (J8-J90)
- Fœtus (J90-Naissance)
- Nouveau-né (J0-J28 post natal)

II. DIAGNOSTIC

1. Interroger la mère et les documents sources

1. Interroger le carnet de santé mère enfant

- Nombre de CPN
- DDR
- Bilans prénataux
- Prophylaxie grossesse

- Pathologies pendant la grossesse
- Travail
- Etat de la mère/travail
- Terme de la grossesse
- Voie accouchement
- Apgar (8-10)
- Mensurations (3500g, T50 cm, PC 35cm)



Bilan prénatal

Biologie

1. Hémogramme
2. Electrophorèse de l'hémoglobine
3. Groupe sanguins (ABO/Rhésus)
4. Glycémie
5. Sérologie VIH
6. Sérologie Toxoplasmose
7. Sérologie rubéole
8. Sérologie Syphilis

Imagerie

9. Echographie (1^{er}, 2^e et 3^e trimestre)

2. Prendre des précautions avant d'examiner l'enfant

- Salle bien éclairée
- Environnement calme et apaisant
- Se laver les mains
- Mettre le nouveau-né sous une lampe chauffante ou sur une table radiante pour ne pas qu'il prenne froid.
- Dêvêtir le nouveau-né
- Porter des gants propres

3. Examiner l'enfant

Observer l'aspect et l'attitude

- Coloration rose
- Quatre membres en flexion (W, M)
- Lobule de l'oreille bien ourlée
- Testicules présents dans les bourses striées (Garçon)
- Grandes lèvres recouvrent les petites (fille)
- Strie plantaire > 2/3 antérieur

Toucher

- Respiration calme et régulières (40-60 cycles/min)
- Fréquence cardiaque 100-160 battements/ min
- Nodule mammaire > 4 mm
- Succion bonne
- Déplier la chevelure pour rechercher un traumatisme
- Rechercher les malformations évidentes

Résumé

- 4CPN, Bilan prénatal réalisé, 3 prophylaxies, grossesse sans incident
- Accouchement normal voie basse
- APGAR 8-10 en 5min
- Poids 2500-4000g, T 46-54 cm, PC 33-37 cm
- Coloration rose, en quadri flexion (W, M)
- FR 40-60 cycles/min, Fréquence cardiaque 100-160 battement/minutes
- Absence de traumatisme et malformation

III. BESOINS ET RÔLES DE SOINS DU NOUVEAU-NE NORMAL

1. Besoins

Les principaux besoins portent sur :

- l'alimentation
- l'hygiène
- la surveillance

2. Rôles de soins de l'agent

Soins propres	Examen du nouveau-né, surveillance de la température, aider la mère à mettre le nouveau-né au sein, rechercher les obstacles à l'allaitement
Soins délégués	Collyre dans les yeux, Vit K1 1 mg en IM, pansement ombilical à la Chlorhexidine, injection de serum Anti-D si mère Rhésus négatif et nouveau-né Rhésus positif.
Soins de collaboration	Accompagné le nouveau-né chez la puéricultrice
Conseils & prévention	CPN, suivi, MILDA, allaitement exclusif...

CONCLUSION

Pour que le nouveau-né, il faut que la mère surveille la grossesse, accouche à l'hôpital en présence d'un personnel qualifié. Les soins prioritaires d'un tel nouveau-né portent sur l'alimentation, les soins prophylactiques et de puéricultures ainsi que la surveillance,

EXAMEN DU NOUVEAU-NE EN SALLE DE NAISSANCE

Objectif général

- Connaître les étapes de l'examen du nouveau-né normal

Objectifs spécifiques

1. Définir les termes : examen du nouveau-né, traumatisme obstétrical, malformation congénitale
2. Décrire les étapes de l'examen du nouveau-né
3. Evaluer la vitalité du nouveau-né en utilisant le score d'APGAR
4. Citer deux principaux groupes d'anomalies au terme de l'examen clinique du nouveau

Plan

Introduction

- I. Examen
- II. Diagnostic
- III. Besoins
- IV. Soins du nouveau-né normal

Conclusion

INTRODUCTION

1. Définitions

- Salle de naissance : Lieu où naît l'enfant. Il peut être approprié ou non approprié. La salle de naissance appropriée est celle de la maternité où il existe du matériel et un personnel qualifié.
- Examen du nouveau-né : il désigne la visite ou consultation d'un être vivant âgé de 0 à 28 jours pour vérifier la vitalité et la présence ou non de malformation ou traumatisme obstétrical.
- Traumatisme obstétrical : ensemble des lésions des parties molles, osseuse, vasculaire ou nerveuse constatées à la naissance ou des jours après la naissance et provoquées par l'acte d'accouchement.
- Malformations congénitales : anomalie de développement constatée chez l'enfant à la naissance ou des jours après la naissance.

2. Intérêt

L'examen du nouveau-né fait partie des soins essentiels du nouveau-né et doit être réalisé en salle d'accouchement après la naissance du bébé. Le but étant de vérifier la vitalité de l'enfant et s'assurer qu'il ne présente pas de traumatisme ni de malformations.

I- EXAMEN

1. Prendre des précautions avant d'examiner l'enfant

- Salle bien éclairée
- Environnement calme et apaisant
- Se laver les mains
- Mettre le nouveau-né sous une lampe chauffante ou sur une table radiante pour ne pas qu'il prenne froid
- Dêvêtir le nouveau-né
- Porter des gants propres

Une fois les précautions prises, il faut conduire l'interrogatoire ensuite évaluer le score d'APGAR et enfin réaliser l'examen physique.

2. Interroger la mère et les documents sources

Interroger le carnet de santé mère enfant

- Nombre de CPN
- DDR
- Bilans prénataux
- Prophylaxie grossesse
- Pathologies pendant la grossesse
- Travail
- Etat de la mère/travail
- Terme de la grossesse
- Voie accouchement
- Apgar (8-10)
- Mensurations (3500g, T50 cm, PC 35 cm)



Bilan prénatal

Biologie

1. Hémogramme
2. Electrophorèse de l'hémoglobine
3. Groupe sanguins (ABO/Rhésus)
4. Glycémie
5. Sérologie VIH
6. Sérologie Toxoplasmose
7. Sérologie rubéole
8. Sérologie Syphilis

Imagerie

9. Echographie (1^{er}, 2^e et 3^e trimestre)

3. Evaluer le score d'APGAR

Signes	0	1	2
A Aspect (couleur de la peau)	Cyanose, généralisée	Cyanose des extrémités	Rose partout
P Pouls (Fréquence cardiaque)	0	< 100/ mn	> 100/mn
G Grimace (qualité du cri)	Absence	Grimace ou geignement	Cri
A Activité (Tonus musculaire)	Hypotonie généralisée	Flexions des extrémités	Quadri flexion
R Respiration (Mouvement respiratoire)	Absente	Irrégulière	Régulière

4. Examiner l'enfant

Observer l'aspect et l'attitude

- Coloration rose
- Quatre membres en flexion (W, M)
- Lobule de l'oreille bien ourlée
- Testicules présents dans les bourses striées (Garçon)
- Grandes lèvres recouvrent les petites (fille)
- Strie plantaire > 2/3 antérieur

Toucher

- Respiration calme et régulières (40-60 cycles/min)
- Fréquence cardiaque 100-160 battements/ min
- Nodule mammaire > 4 mm



- Succion bonne
- Déplier la chevelure pour rechercher un traumatisme
- Rechercher les malformations évidentes

Résumé

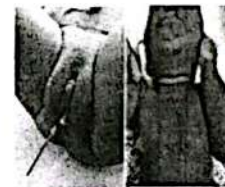
- 4CPN, Bilan prénatal réalisé, 3 prophylaxies, grossesse sans incident
- Accouchement normal voie basse
- APGAR 8-10 en 5min
- Poids 2500-4000g, T 46-54 cm, PC 33-37 cm
- Coloration rose, en quadri flexion (W, M)
- FR 40-60 cycles/min, Fréquence cardiaque 100-160 battement/minutes
- Absence de traumatisme et malformation

5. Résultat de l'examen

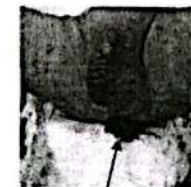
Au terme de l'examen, 2 grandes situations se présentent. Le nouveau-né est soit normal soit anormal. Le nouveau-né anormal est soit à risque ou soit malade.

❖ Cas du nouveau-né normal

La crise génitale est due à l'effet de la prolactine au niveau des seins et du vagin. Le méconium représente les premières selles du nouveau-né.



Crise génitale



Méconium



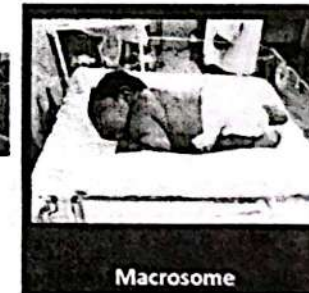
Nouveau-né normal

❖ Cas du nouveau-né anormal

• Nouveau-né à risque



Prématuré



Macrosome



Hypotrophe

• **Nouveau-né avec traumatisme obstétrical**



Paralysie du plexus brachial gauche

Cephalhématome aggravé par le massage

• **Nouveau-né avec malformations**



Spina bifida



Anencéphalie



Anencéphalie +
myéloméningocèle



Pieds Bots

• **Nouveau-né avec malformations**



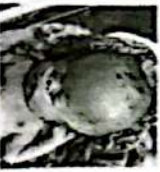
Fente labio-palatine



Omphalocèle



Ichtyose congénitale (Bébé collodion)



Hydrocéphalie



Imperforation anale



Poly malformation

3- **Rôles de soins de l'agent**

Soins propres	Examen du nouveau-né, surveillance de la température, aider la mère à mettre le nouveau-né au sein, rechercher les obstacles à l'allaitement
Soins délégués	Collyre dans les yeux, Vit K1 1 mg en IM, pansement ombilical à la Chlorthexidine, injection de serum Anti-D si mère Rhésus négatif et nouveau-né Rhésus positif.
Soins de collaboration	Accompagné le nouveau-né chez la puéricultrice
Conseils & prévention	CPN, suivi, MILDA, allaitement exclusif...

CONCLUSION

Si au terme de l'examen, le nouveau-né n'a pas de problème de maladie alors soins d'hygiène et de puériculture. Dans le cas contraire il faut organiser la référence. Dans tous les cas de figure, il faut une surveillance attentive du nouveau-né.

NOUVEAU-NE PREMATURE

Objectif général

- Reconnaître un nouveau-né prématuré pour une meilleure participation à ses soins

Objectifs spécifiques

1. Citer les causes de la prématurité
2. Décrire les signes du prématuré
3. Citer les principaux problèmes du prématuré
4. Enoncer les rôles de soins de l'IDE dans la prise en charge du prématuré
5. Citer les critères de sortie du prématuré

Plan

Introduction

- I. Causes
- II. Cas clinique
- III. Problèmes & devenir
- IV. Rôles de soins

Conclusion

INTRODUCTION

1. Définitions

- Prématuré = Nouveau-né dont l'âge gestationnel est inférieur à 37 SA (semaines d'aménorrhée)
- 4 groupes de prématurés
 - o Petit prématuré : [35-37 [SA.
 - o Moyen prématuré : [33 - 35 [SA
 - o Grand prématuré : [28 - 33[SA
 - o Extrême prématuré : [22-28[SA

2. Intérêt

- Causes fréquentes d'hospitalisation et de décès en néonatalogie
- Prise en charge coûteuse
- Problèmes des séquelles parfois invalidantes

I. CAUSES

Il existe deux grands groupes de causes :

- Causes médicales ou provoquées
- Causes spontanées d'origine maternelle ou fœtale

II- DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

Cas clinique

Mlle **Nbalin'dé**, étudiante à l'INFAS, vient d'accoucher d'un garçon. Elle ne connaît pas sa date des dernières règles. Son concubin **Greglementeur** refuse la paternité car le bébé lui paraît à terme. Mlle Nbalin'dé, est furieuse et soutient que son bébé est bel et bien prématuré.



Nouveau-né Prématuré de NBALIN'DE



Nouveau-né normal à terme

Pour reconnaître le nouveau-né prématuré, il faut interroger les **documents sources** (carnet de santé de la mère et de l'enfant, dossier obstétrical) ensuite **examiner le nouveau-né** (critères morphologiques, critères de maturation).

a) Interroger les documents sources

Le carnet de santé-mère enfant renseigne

- Nombre de CPN
- DDR
- Bilans prénataux
- Prophylaxie grossesse
- Pathologies pendant la grossesse
- Travail
- Etat de la mère/travail
- Terme de la grossesse
- Voie accouchement
- Score Apgar
- Mensurations



Bilan prénatal

Biologie

1. Hémogramme
2. Electrophorèse de l'hémoglobine
3. Groupe sanguins (ABO/Rhésus)
4. Glycémie
5. Sérologie VIH
6. Sérologie Toxoplasmose
7. Sérologie rubéole
8. Sérologie Syphilis

Imagerie

9. Echographie (1^{er}, 2^e et 3^e trimestre)

b) Examiner le nouveau-né

❖ Précautions à prendre avant l'examen physique

- Salle bien éclairée
- Environnement calme et apaisant
- Se laver les mains
- Mettre le nouveau-né sous une lampe chauffante ou sur une table radiante pour ne pas qu'il prenne froid
- Dêvêtir le nouveau-né

- Porter des gants propres

❖ Examen physique

L'examen physique réalisé en suivant les règles d'asepsies comporte deux volets : l'observation et le toucher.

▪ Observation de l'aspect et l'attitude

- Poids inférieur à 2500g
- Taille et PC inférieurs à la normale
- Coloration rouge brun
- Peau fine, fragile et luisante
- Peau recouverte d'un enduit blanchâtre (vernix caseosa)
- Lanugo
- Quatre membres en flexion incomplète
- Lobule de l'oreille absent
- Testicules absents dans les bourses lisse et non striées (Garçon)
- Grandes lèvres ne recouvrent pas les petites (fille)

- Strie plantaire inférieur au 1/3 antérieur

Toucher

- Respiration souvent irrégulière avec des apnées ou pauses
- Fréquence cardiaque 100-160 battements/ min
- Nodule mammaire en dessous de 4 mm
- Succion faible
- Déplier la chevelure pour rechercher un traumatisme
- Rechercher les malformations évidentes



2. Diagnostic différentiel

Il ne pas confondre le nouveau-né prématuré à un :

- nouveau-né hypotrophe
- nouveau-né post terme avec signes de post maturité

III- PROBLEMES ET DEVENIR

1. Problèmes

- Souffrance cérébrale
- Détresse respiratoire (Maladie des membranes hyalines...)
- Hypothermie

- Infections
- Hémorragie
- Hypoglycémie, hypocalcémie
- Troubles digestifs (entérocolite)

2. Devenir

- Neurologique : IMC, surdité, cécité
- Respiratoire : bronchiolite, asthme,
- Croissance : retard pondéral rattrapé entre le 3e et 6e mois
- Mortalité entre 25 et 50% en Afrique

IV-ROLES DE SOINS DE L'AGENT DE SANTE

L'agent de santé a 4 rôles de soins chez le nouveau-né prématuré indiqués dans le tableau ci-après.

Soins propres	Soins délégués	Soins de collaboration	Conseils & prévention
- Soins Mère-Kangourou - Placer le nouveau-né en incubateur ou table chauffante - Placer le nouveau-né dans une enceinte de Hood - Placer une lunette nasale - Prendre les constantes	- Placer une perfusion, - Placer une sonde naso-gastrique - Administrer des médicaments - Brancher le nouveau-né sous oxygène - Surveiller le nouveau-né	- Collaborer avec le médecin à la réalisation des examens de biologie et de radiologie	- CPN, - Bilan Prénatal - Prophylaxie anténatales - Asepsies - Allaitement - indiquer le quand revenir - suivi

❖ Critères de sortie d'hospitalisation

- Bonne succion
- Prend du poids régulièrement,
- Température corporelle normale (36-37°5 Celsius),
- Respiration et coloration cutanée normales (FR 40-60 cycles/min, coloration rose)
- Fréquence cardiaque est normale (FC 100-160 battements/min)
- Urine et fait ses selles normalement
- Ne vomit pas

CONCLUSION

- Nouveau-né à risque
- Causes médicales et spontanées
- Diagnostic essentiellement clinique
- Morbidité et mortalité élevé
- Rôles préventifs et curatifs essentiel du soignant dans la PEC

ALLAITEMENT

Objectif général

- Promouvoir l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois et la poursuite de l'allaitement jusqu'à 2 ans.

Objectifs spécifiques

1. Définir correctement l'allaitement exclusif
2. Expliquer correctement la physiologie de la lactation
3. Comparer sans erreur dans un tableau le lait humain et le lait de vache
4. Enumérer correctement les principaux avantages de l'allaitement
5. Décrire correctement les étapes de l'allaitement
6. Décrire sans erreur la technique de mise au sein
7. Identifier les principaux paramètres de surveillance de l'allaitement
8. Communiquer convenablement avec les parents sur les incidents et contre-indications de l'allaitement

Plan

Introduction

1. Physiologie de la lactation
2. Composition du lait maternel
3. Avantages et modalités de l'allaitement
4. Aspects pratiques et problèmes de l'allaitement
5. Politique de l'allaitement

Conclusion

INTRODUCTION

1. Définitions

- Allaitement : mode naturel de l'alimentation du bébé par le sein
- Allaitement exclusif : Nourrir exclusivement le bébé avec le lait maternel de

0 à 6 mois sans adjonction d'eau ni de jus exception faite des médicaments (23% en CI)

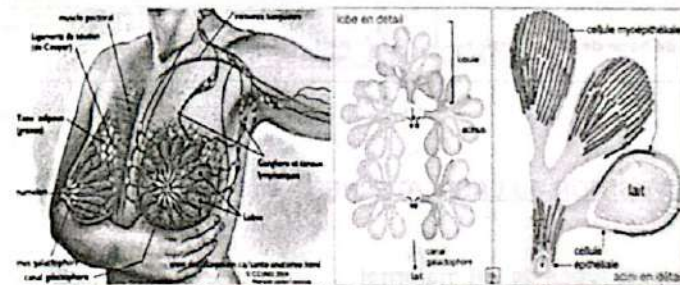
- Allaitement prépondérant : le bébé reçoit en plus du lait maternel de l'eau ou du jus

2. Intérêt

- Epidémiologique
- Nutritionnel et de lutte contre les maladies
- Socio-économique
- Psychoaffectif

I- PHYSIOLOGIE DE LA LACTATION

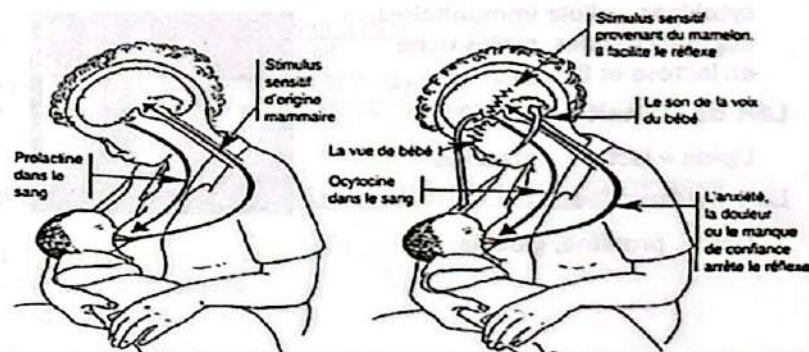
1. Anatomie du sein



2. Physiologie de la lactation

Le réflexe de sécrétion du lait ou réflexe prolactinique.

Le réflexe ocytotique ou le réflexe d'éjection du lait.



CONCLUSION

- Nouveau-né à risque
- Causes médicales et spontanées
- Diagnostic essentiellement clinique
- Morbidité et mortalité élevée
- Rôles préventifs et curatifs essentiels du soignant dans la PEC

ALLAITEMENT

Objectif général

- Promouvoir l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois et la poursuite de l'allaitement jusqu'à 2 ans.

Objectifs spécifiques

1. Définir correctement l'allaitement exclusif
2. Expliquer correctement la physiologie de la lactation
3. Comparer sans erreur dans un tableau le lait humain et le lait de vache
4. Énumérer correctement les principaux avantages de l'allaitement
5. Décrire correctement les étapes de l'allaitement
6. Décrire sans erreur la technique de mise au sein
7. Identifier les principaux paramètres de surveillance de l'allaitement
8. Communiquer convenablement avec les parents sur les incidents et contre-indications de l'allaitement

Plan

Introduction

1. Physiologie de la lactation
2. Composition du lait maternel
3. Avantages et modalités de l'allaitement
4. Aspects pratiques et problèmes de l'allaitement
5. Politique de l'allaitement

Conclusion

INTRODUCTION

1. Définitions

- Allaitement : mode naturel de l'alimentation du bébé par le sein
- Allaitement exclusif : Nourrir exclusivement le bébé avec le lait maternel le

0 à 6 mois sans adjonction d'eau ni de jus exception faite des médicaments (23% en CI)

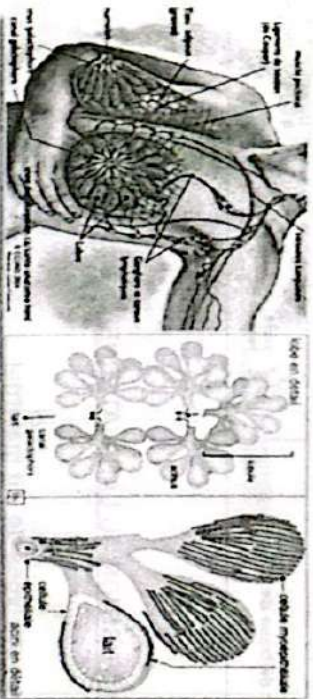
- Allaitement prépondérant : le bébé reçoit en plus du lait maternel de l'eau ou du jus

2. Intérêt

- Epidémiologique
- Nutritionnel et de lutte contre les maladies
- Socio-économique
- Psychoaffectif

1- PHYSIOLOGIE DE LA LACTATION

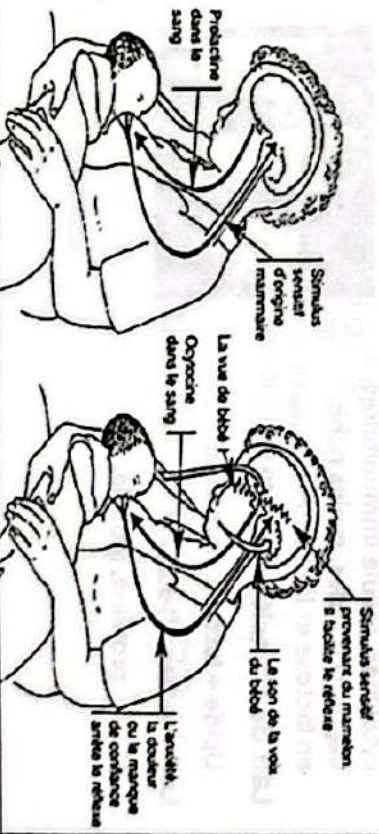
1. Anatomie du sein



2. Physiologie de la lactation

Le réflexe de sécrétion du lait ou réflexe prolactinique.

Le réflexe oxytocinique ou le réflexe d'éjection du lait.



MODE DE L'HORMONE	CONDITION D'APPARITION	STRUCTURE CELL	EFFETS
Oxytocine	 émotions et/ou la peur-hypothalamus libère une ou plusieurs fois de l'oxytocine	 fibre myo-épithéliale	contraction des fibres myo-épithéliales Mouvement dans l'arbre sécrétoire progression et augmentation de la circulation dans l'arbre vasculaire
Prolactine	 l'ant-hypophysaire libère la prolactine dès le début de la lactation	 dans l'arbre sécrétoire, les acini	libération du lait, c'est à dire synthèse intracellulaire des différents éléments constitutifs du lait maternel : - lactose - protéines - lipides "fait l'éponge vasculaire"
Taux de base de la prolactine			

II. COMPOSITION DU LAIT MATERNEL

1. Différents types de lait maternel

Colostrum (J0-J7)

Ig A, facteurs de croissance, cytokines, cellule immunitaires, oligosaccharides, moins riche en lactose et lipide

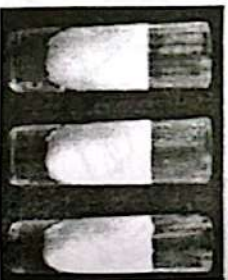
Lait de transition (J7-j21)

Lipide + lactose, protéine

Lait mature (>J21)

Lipide, protéine, glucide, eau

Colostrum → Mature Milk



2. Lait maternel supérieur au lait de vache

	lait de mère (100ml)	lait de vache (100ml)
Bactéries pathogènes	Absentes	Possibles
Anticorps	Présents	Présents
Facteur de croissances	Présents	Présents
Lipides (g)	3,6 à 4	3,5
Protéines (g)	1,1 à 1,8	3,5
Glucides (g)	5,8 à 7	55
Lactose	4,8 à 5	Absent
Oligosaccharides	1 à 2	-
Minéraux (mg)	0,05 à 1	0,05
Fer	15	96
Eau	Quantité suffisante	Ajouter nécessaire
Vitamines A (Uj)	202	250
B1, B2, PP (mg)	0,02; 0,04; 0,2	0,04; 0,15; 0,2
D (Uj)	7	-

III. AVANTAGES ET MODALITES DE L'ALLAITEMENT

1. Avantages de l'allaitement

- Pour l'enfant
 - Croissance harmonieuse
 - Développement cognitif optimal
 - Prévention des maladies
 - Favorise l'attachement à la mère
 - Diminution risque de décès
- Pour la mère
 - Réduit risque de décès
 - Protège des grossesses précoces
 - Economique
 - Favorise attachement à son enfant

2. Modalités de l'alimentation (OMS)

- 0-6 mois : Allaitement exclusif
- 6-12 mois: Seins + compléments /aliments locaux
- 12-24 mois: Seins + repas familial
- 24 mois: sevrage définitif

IV. ASPECTS PRATIQUES ET PROBLEMES DE L'ALLAITEMENT

1. Conseils

- Pendant la grossesse
- A la naissance

- Après la naissance
- initier allaitement dans l'heure après accouchement
- Rechercher les obstacles à l'allaitement
- **Conseils à la Mère allaitante**
- 3 Repas équilibrés par jour
- 1,5 à 2 litres d'eau de boisson/j en dehors des repas
- Arrêt de la consommation de stupéfiants (alcool, tabac, drogue etc.)
- Hygiène corporelle et vestimentaire
- Donner à téter chaque fois que l'enfant réclame
- **Surveillance de l'enfant allaité**
- Nombre de tétée par jour (à volonté 8-9 fois/j)
- Poids (prise de poids 25-30 g/j)
- Selles (couleur jaune-or aspect œufs brouillés)
- visite régulière en consultation

2. Aspects techniques de l'allaitement



Critères d'un bon positionnement au sein

1. Dos du bébé repose sur avant bras
2. Nuque du bébé repose sur le pli du coude
3. Ventre du bébé fait face et en contact avec celui de la mère
4. Bouche du bébé est au contact du mamelon

Position confortable pour la mère et l'enfant



Critères d'une tétée efficace

1. succion lente, profonde entrecoupée de pause
2. On entend le bébé déglutir le lait maternel

Critères d'une bonne prise de sein

1. Bouche du bébé grandement ouverte prend largement l'aréole
2. Menton du bébé touche le sein
3. Lèvre inférieure du bébé est éversée et l'aréole peu visible en haut



Plaie du mamelon

Engorgement des seins

Mauvaise technique de mise au sein

3. Problèmes et ébauches de solutions

Les problèmes résultent le plus souvent d'une mauvaise technique ou une maladie chez la mère ou une maladie chez le nouveau-né.

• Hypo galactorrhée

- Soutien psychologique de la mère

• Allaitement et travail

- Tiré le lait avec un tire lait
- Alimenté l'enfant avec le lait extrait durant la période d'absence de la mère

• Maladies

- Engorgement des seins (bain d'eau tiède, antalgique)
- Crevasse des seins (antiseptique, antalgique)
- Abscess des seins (antibiotique après avis médical)

• Allaitement et VIH

- Poursuivre allaitement si mère sous trithérapie
- Sevrage à 12 mois si enfant non infecté dans le cas contraire sevrage à 24 mois comme les autres enfants

V- POLITIQUES DE L'ALLAITEMENT

1. Facteurs de déclin

- Fabrication et promotion des formules infantiles par industrie pharmaceutique
- Activité professionnelle de la mère
- Manque de soutien psychologique de l'allaitante
- Préoccupation esthétique de la mère
- Retard de la montée laiteuse

2. Dix conditions de l'initiative Hôpitaux Amis des bébés (IHAB)

1. Politique d'allaitement maternel écrite sue de tous
2. Connaître les techniques de mise en œuvre de cette politique
3. Informer toutes les gestantes des avantages de l'allaitement
4. Aider les mères à mettre leur bébé au sein dans les 30min suivant la naissance.
5. Indiquer aux mères la pratique de l'allaitement et l'entretien de la lactation si séparées de leur enfant
6. Dire aux mères de pratiquer l'allaitement exclusif
7. Laisser l'enfant avec sa mère 24 heures par jour
8. Encourager l'allaitement à la demande de l'enfant
9. Ne pas donner de tétine artificielle ou sucette aux enfants allaités
10. Encourager la constitution d'associations de soutien à l'allaitement maternel et adresser les mères à ladite association dès leur sortie de l'hôpital ou de la clinique.

VI- ROLES IDE/SF A 4 NIVEAUX

- Propre
- Délégué
- Collaboration
- Conseils et prévention

CONCLUSION

- Allaitement, méthode naturelle universelle simple, économique et sans danger
- Effets bénéfiques pour le bébé et la mère
- Importance de suivre les recommandations de l'OMS/UNICEF sur l'allaitement

CROISSANCE NORMALE DE L'ENFANT

Objectif général

- Connaître les principales étapes de la croissance de l'enfant entre 0 et 10 ans

Objectifs spécifiques

1. Définir le terme croissance somatique, maturation
2. Enumérer les facteurs de la croissance de l'enfant
3. Citer les instruments utilisés pour apprécier la croissance quantitative
4. Décrire les étapes de la croissance quantitative et qualitative de 0 à 10 ans

Plan

Introduction

- I. Facteurs de la croissance
- II. Physiologie de la croissance
- III. Surveillance de la croissance
- IV. Etapes de la croissance somatique
- V. Etape de la croissance qualitative
- VI. Rôles de soins

Conclusion

INTRODUCTION

1. Définition

La croissance est un processus dynamique qui comprend 2 volets : quantitatif et qualitatif.

- La croissance quantitative ou somatique qui correspond à l'augmentation en taille de poids, de surface ou de volume des différentes parties du corps et de tous les organes et tissus qui le composent
- La croissance qualitative ou maturation qui correspond à la multiplication et perfectionnement des structures et des fonctions au cours de l'évolution vers l'état adulte

2. Intérêt

Le suivi de la croissance est important en pédiatrie car il permet de détecter précocement une anomalie de développement et de la prendre en charge.

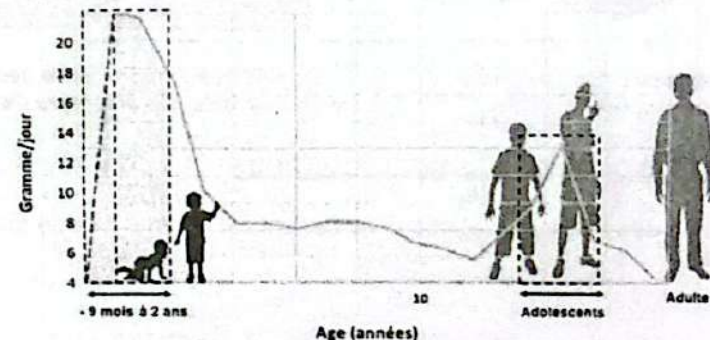
I. FACTEURS DE LA CROISSANCE

Les facteurs de la croissance sont :

- Héritaires
- Hormonaux
- Environnements

II. PHYSIOLOGIE DE LA CROISSANCE

La croissance est un processus dynamique avec des phases de croissance rapides et des phases de croissance lente. La figure suivante montre la dynamique de la croissance chez l'enfant selon l'âge.



III. SURVEILLANCE DE LA CROISSANCE**1. Croissance somatique quantitative**

Pour apprécier la croissance somatique l'agent de santé utilise des outils objectifs de mesure.

- Poids
- Pèse-bébé (<2 ans), pèse-personne (>2 ans)
- Taille
- Toise Horizontale (< 2 ans), Toise verticale (> 2 ans)
- Périmètre crânien / périmètre brachial
- Mètre ruban

2. Croissance qualitative

Pour apprécier la croissance qualitative l'agent de santé se base sur :

- la fontanelle (antérieure et postérieure)
- l'éruption des dents
- l'apparition des points d'ossification (domaine du médecin spécialiste)

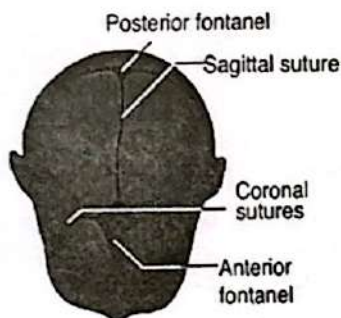
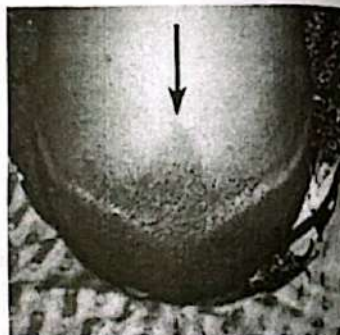


Schéma du crâne vu de haut montrant les fontanelles



Crâne d'un nourrisson vu de haut montrant la fontanelle antérieure (flèche)

IV. ETAPES DE LA CROISSANCE SOMATIQUE

La norme de croissance somatique de l'enfant est résumé dans le tableau ci-après.

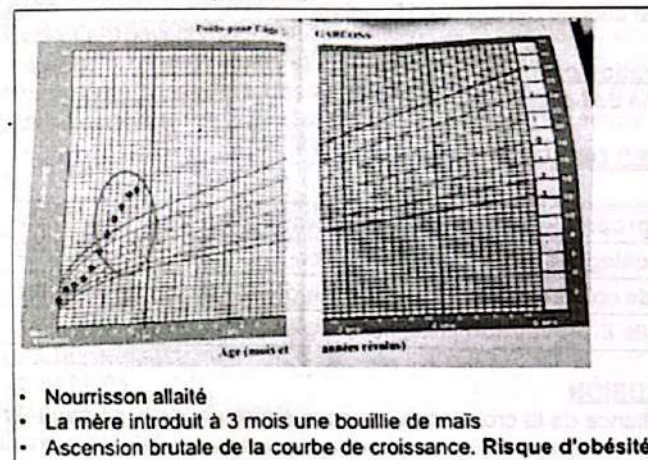
Âge (mois)	Poids (Kg)	Taille (cm)	PC(cm)	SC (m ²)
Naissance	3	50	35	0,2
3 mois	6 (PNx2)	65	41	
9 mois	8	70	45	0,40 (SCNx2)
12 mois	9 (PNx3)	75	47	
24 mois	12 (PNx4)	85	48	
3 ans	14	95	49	0,6 (SCNx3)
4 ans	16	100 (TNx2)	51	
7 ans	22	120	52	
10 ans	30	135	53	

1. Aspects pratiques de la surveillance de la croissance somatique

- Courbe de croissance
 - o Tracer
 - o Interpréter
 - o Notifier

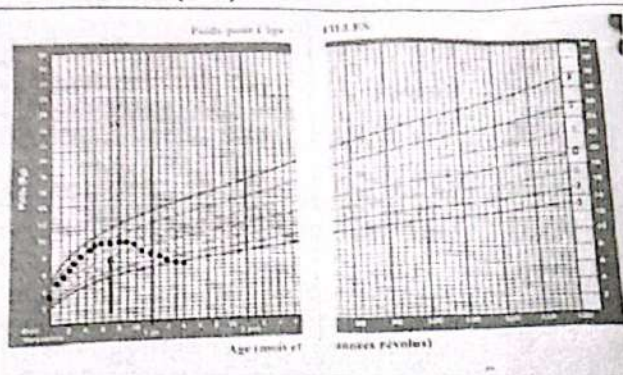
2. Exemple de courbe de croissance

- Courbe de croissance (Garçon)



- Nourrisson allaité
- La mère introduit à 3 mois une bouillie de maïs
- Ascension brutale de la courbe de croissance. Risque d'obésité

• Courbe de croissance (Fille)



- Allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Diversification mal conduite.
- Courbe stationnaire puis cassure. **Risque de malnutrition**

V. ETAPES DE LA CROISSANCE QUALITATIVE

1. Fermeture des fontanelles

- Postérieure 2-3 mois
- Antérieure 18 mois

2. Eruption des dents

- date d'apparition varie selon les enfants
- retard si aucune dent après 15 mois

3. Maturation osseuse

- domaine du spécialiste

VI. ROLES DE SOINS

Soins propres	Prendre les mensurations, tracer de la courbe de poids
Soins délégués	Administration d'hormone de croissance...
Soins de collaboration	Accompagné pour la radiographie des mains...
Conseils & prévention	Nutrition, hygiène

CONCLUSION

- Surveillance de la croissance, un point important de la pédiatrie préventive

**DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR
NORMAL DE L'ENFANT**

Objectif général

- Connaître les principales étapes développement psychomoteur normal de l'enfant entre 0 et 10 ans

Objectifs spécifiques

1. Définir le terme développement psychomoteur
2. Enumérer les facteurs du DPM de l'enfant
3. Citer les moyens utilisés pour apprécier le DPM
4. Décrire les étapes du DPM normal de l'enfant entre 0 à 10 ans

Plan

Introduction

- I. Facteurs favorisant et limitant
- II. Surveillance du DPM
- III. Moyens d'évaluation du DPM
- IV. Etapes du DPM
- V. Rôles de soins

Conclusion

INTRODUCTION

1. Définition

Le développement psychomoteur est un processus dynamique qui comprend 2 volets : acquisitions psychiques et motrices.

Il se définit comme l'ensemble des acquisitions psychiques et motrices de l'enfant aboutissant à terme à la posture et pensées de type adulte.

2. Intérêt

Le suivi du développement psychomoteur permet de détecter précocement une anomalie de développement et la prendre en charge.

I. FACTEURS FAVORISANTS ET LIMITANT LE BON DPM

1. Facteurs favorisant

- Héritaires
- Intégrité du système nerveux
- Environnements

2. Facteurs limitant le bon DPM

- Maladies Héritaires
- Maladies du système nerveux (souffrance cérébrale, infection...)
- Ictère nucléaire
- Maladies métaboliques (Phénylcétonurie....)

II. SURVEILLANCE DU DPM

- Examen clinique
- Tests d'intelligence
- Jeux

III. MOYENS D'EVALUATION DU DPM

- Motricité
- Préhension
- Langage
- Compréhension

IV. ETAPES DU DPM

Age	Motricité	Préhension	Langage	Compréhension
0 à 1 mois	Quadri flexion	reflexe de Grasping	Attentive au son et à son entourage	Sourire aux anges
3 mois	Tient la tête dans l'axe; Disparition des reflexes archaïques	Tient un objet place dans sa main pendant quelques secondes	Emet les sons ("Aah, reeu...")	Sourire réponse
6 mois	Tenue assise en trépied Attrape ses pieds Tenue debout sautille (=stade du sauteur)	Porte l'objet à la bouche	Lallation.	Tend les bras pour être pris
9 mois	Marche à 4 pattes Tient debout avec appui	Pince pouce indexe	Emet les sons "da-da-da ba-ba-ba.."	À peur de l'étranger Fait bravo et au revoir
12 mois	Marche avec appui	Introduit et retire un objet dans une boîte	Dit "papa maman"	Pointe du doigt,

15 mois	Marche seule acquise; Monte les escaliers à 4 pattes; s'agenouille et se relève sans aide	gribouille; tient sa cuillère mais la met à l'envers dans la bouche	"papa maman" Demande les objets en les montrant du doigt	Aime jeté, pousser, renvoyer
18 mois	Monte un escalier en se tenant à la rampe	Tape le pied dans le ballon place correctement le triangle, le rond, le rond après démonstration	Vocabulaire de 10 à 20 mots	Imite les adultes dans les tâches ménagères
24 mois	Monte et descend un escalier seul en posant les deux pieds sur la même marche; Court vite, sauté, danse, tourne en cercle	Mange proprement seul; Fait une tour de 6 cubes. Copie un rond	Réunit 2 ou 3 mots dans une phrase; utilise les verbes; explosion du vocabulaire (parle constamment	Comprend et exécute des ordres en 2 parties jeu symbolique: fait semblant de donner à manger..... Propreté diurne (vers 2,5 ans)
3 ans	Monte et descend les escaliers comme un adulte Fait du tricycle	S'habille seul, mais a besoin d'aide pour les boutons et fermeture éclair dessine un bonhomme têtard; copie une croix (vers 3,5 ans)	L'âge « du pourquoi ? » Apparition du « non »	Connaît quelque chanson enfantines; propreté diurne et nocturne; Dit son nom et son âge; connaît son sexe
4 ans	Fait de la bicyclette sans roue latérale	S'habille seul, sauf pour les lacets des chaussures Copie un carré	Connaît l'utilisation des objets familiers; connaît la notion de haut, bas grand et petit	Début des jeux en groupe; Connaît les couleurs Latéralisation de la main et du pied Apparition du complexe d'Œdipe (vers 4,5 ans)
6 à 10 ans		Lace ses chaussures; tape la balle dans le but; dessine un triangle; Début de l'écriture d'imprimerie à 6 ans	Dit "papa maman"	Nomme les jours de la semaine; connaît sa droite et sa gauche, son adresse et son numéro de téléphone; phase de latence

V. ROLES DE SOINS

Soins propres	Consigner l'évaluation dans le carnet de santé, organiser la référence si suspicion d'anomalies
Soins délégués	Participer à surveillance si anomalie...
Soins de collaboration	Accompagné pour les explorations (TDM, audiométrie, fond d'œil, EEG...)
Conseils & prévention	Nutrition, hygiène, suivi

CONCLUSION

- Surveillance du DPM, un point important de la pédiatrie préventive

DIARRHÉE AIGUË ET DESHYDRATATION

Objectif général

- Connaître la diarrhée aiguë et déshydratation pour des soins appropriés

Objectifs spécifiques

1. Définir les termes : Diarrhée aiguë, Déshydratation
2. Citer les facteurs favorisants de la diarrhée
3. Citer les causes de la diarrhée aiguë
4. Énoncer les rôles de soins de l'agent de santé

Plan

Introduction

I. Facteurs favorisants

II. Causes

III. Évaluation de l'état d'hydratation

IV. Diagnostic différentiel

V. Problèmes et besoins

VI. Rôles de soins

Conclusion

INTRODUCTION

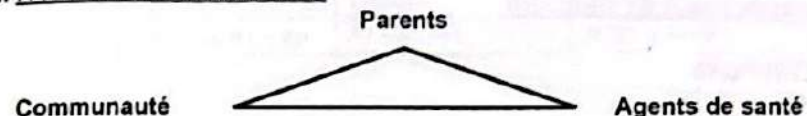
1. Définition

- Diarrhée aiguë : émission d'au moins trois selles molles ou liquides par 24 heures évoluant depuis moins de 14 jours

2. Intérêt

- Motifs fréquents
- Causes variées
- Complications: déshydratation, dénutrition

I. FACTEURS FAVORISANTS



II. CAUSES

On distingue 2 groupes de causes :

- Diarrhée aiguë infectieuse
- Diarrhée aiguë non infectieuse

III. ÉVALUATION DE L'ÉTAT D'HYDRATATION

Etat général	Normal	Agité, irritable	Léthargique ou Inconscient
Yeux	Normaux	Enfoncés	Très enfoncés
Larmes	Présentes	Absentes	Absentes
Bouche	Humides	Sèches	Très sèches
Soif	Pas de soif	boit avec avidité	Incapable de boire
Pli cutané	S'efface rapidement	S'efface lentement	S'efface très lentement
Conclusion	Pas de signes de DesH2O	signes évidents de DesH2O	signes sévères de DesH2O
Plan TTT	Plan A	Plan B	Plan C



THIÈRE KONAN AKA E. Luma
professeur DESCES and 2018

Images de nourrissons déshydratés

IV. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Ne pas confondre diarrhée avec :

- Selles semi-liquides de l'enfant nourri au sein

V. PROBLEMES ET BESOINS**1. Problèmes**

- Déshydratation
- Dénutrition
- Hygiène

2. Besoins

- Alimentation
- Hygiène
- Surveillance

VI- ROLES DE SOINS

Soins propres	Nettoyer l'enfant Aider à alimenter l'enfant Réhydratation (Plan A, B, C) Surveillance...
Soins délégués	Administrer du Zinc comprimé voie orale pendant 10 jours. Entre 0 et 6 mois 10mg et 20 mg par jour entre 6 mois et 5 ans.
Soins de collaboration	Participation à la réalisation du bilan biologique
Conseils & prévention	Dietétique, Hygiène, Protection

• Plan A

Age	Quantité de SRO après chaque selle molle	Quantité de SRO à fournir pour le traitement à domicile
Moins de 24 mois	50-100ml	500ml /jour
2 à 10 ans	100-200ml	1000ml /jour
10ans ou plus	Autant qu'il en voudra	2000ml /jour

• Plan B

Le traitement du plan B s'applique à l'hôpital pendant 4heures puis à domicile.
Quantité de liquide : 75ml/kg en 4heures

• Plan C

Le traitement s'applique à l'hôpital pendant au minimum 24heures

Age	Administrer d'abord 30ml/kg en	Puis administrer 70ml/kg en
Nourrisson de moins d'un an	1 heure	5 heures
Enfant âgé de plus d'un an	30 minutes	2H30 minutes

CONCLUSION

- Symptôme fréquent
- Causes variées
- Prise en charge symptomatique et étiologique

VOMISSEMENTS**Objectif général**

- Connaître les vomissements pour des soins appropriés

Objectifs spécifiques

1. Définir les termes : vomissements, fausse route, régurgitation, mérycisme, vomique, dénutrition, déshydratation
2. Citer les facteurs favorisant des vomissements
3. Citer 6 causes de vomissements (3 aigus, 3 chroniques)
4. Enoncer les rôles de soins de l'agent de santé

Plan

Introduction

- I. Facteurs favorisants
 - II. Causes
 - III. Diagnostic différentiel
 - IV. Problèmes et besoins
 - V. Rôles de soins
- Conclusion

INTRODUCTION

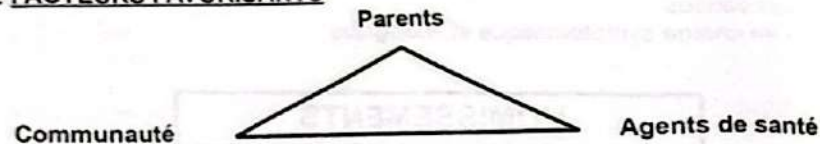
1. Définition

- Rejet actif par la bouche d'une partie ou la totalité du contenu gastrique avec participation du diaphragme

2. Intérêt

- Motifs fréquents
- Causes variées
- Complications : déshydratation, dénutrition, fausse route

I. FACTEURS FAVORISANTS



II. CAUSES

On distingue 2 groupes de causes :

- Vomissements aigus
- Vomissements habituels ou chroniques

III. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Il ne faut pas confondre vomissement avec :

- Régurgitation
- Mérycisme
- Vomique

IV. PROBLEMES ET BESOINS

1. Problèmes
 - Déshydratation
 - Dénutrition
 - Fausse route
 - Hygiène
2. Besoins
 - Alimentation
 - Hygiène
 - Surveillance

V. ROLES DE SOINS

Soins propres	Nettoyer l'enfant Aider à alimenter l'enfant Surveillance
Soins délégués	Administer un antiémétisant...
Soins de collaboration	Participation à la réalisation du bilan biologique...
Conseils & prévention	Diététique, Hygiène, Protection

CONCLUSION

- Symptôme fréquent
- Causes variées
- Prise en charge symptomatique et étiologique

PRISE EN CHARGE INTEGREE DES MALADIES DE L'ENFANT ET DU NOUVEAU-NE (PCIMEN)

Objectif général

- Connaître la stratégie PCIMEN pour des soins appropriés chez l'enfant

Objectifs spécifiques

1. Définir les termes : PCIMEN, maladies, décès, morbidité, mortalité,
2. Citer les objectifs de la PCIMEN
3. Enumérer les maladies cibles de la PCIMEN
4. Citer les directives de la PCIMEN
5. Evaluer l'enfant malade âgé de 1 semaine à 5 ans
6. Classer l'enfant malade âgé de 1 semaine à 5 ans

Plan

Introduction

I. Objectifs de la PCIMEN

II. Principales causes de maladies et de décès chez l'enfant

III. Directives PCIMEN

Conclusion

INTRODUCTION**1. Définition**

« Stratégie intégrée développée par l'OMS et l'UNICEF sous forme d'un arbre décisionnel dans le but d'assurer une prise en charge globale des maladies les plus fréquentes de l'enfant et se concentre sur les principales causes de décès »

2. Intérêt

Cette stratégie a été développée dans les années 2000 par l'OMS et l'UNICEF et destinée aux pays à ressources pour réduire chez l'enfant la mortalité, la fréquence, la gravité des maladies, les invalidités et contribuer à améliorer la croissance et le développement de l'enfant.

I. OBJECTIFS DE LA PCIMEN

- Améliorer les compétences du personnel de santé
- Améliorer le système sanitaire
- Améliorer les pratiques familiales et communautaires

II. PRINCIPALES CAUSES DE MALADIES ET DE DECES CHEZ L'ENFANT

- Malnutrition
- Pneumonie
- Diarrhée aiguë
- Rougeole
- Paludisme
- Infections néonatales
- VIH/sida

III. DIRECTIVES PCIMEN

- Identification de l'enfant et sa famille
- Evaluer l'état de l'enfant
- Classer la ou les maladies de l'enfant
- Déterminer les traitements
- Traiter l'enfant
- Communiquer et conseiller les parents

1. Evaluer l'enfant

- Rechercher les signes de danger
- Poser les questions sur les principaux symptômes

- Etudier de manière approfondie tout symptôme important
- Vérifier l'état nutritionnel
- Vérifier l'état vaccinal
- Contrôler si l'enfant a d'autres problèmes de santé.

2. Classer l'enfant

Classer les maladies de l'enfant en employant le système de tri selon un code de couleur (vert, jaune, rose) pour inscrire dans la catégorie appropriées les principaux symptômes de l'enfant et son état nutritionnel.

2.1. Si hospitalisation

- Déterminer les soins pré-transfert urgents indispensables selon la classification
- Traiter l'enfant: soins urgents avant le transfert
- Faire hospitaliser l'enfant:
 - expliquer à la raison du transfert
 - dissiper les craintes
 - aider à résoudre les problèmes
 - rédiger une note d'hospitalisation
 - donner des instructions et fournir ce dont l'enfant a besoin pendant le transfert

2.2. Pas d'hospitalisation

- Déterminer le traitement nécessaire et/ou les conseils à donner selon la classification
- Traiter l'enfant
 - donner la première dose de médicament par VO
 - expliquer comment administrer le médicament
 - expliquer comment traiter les infections locales
 - vacciner l'enfant si nécessaire
- Conseiller la mère
 - évaluer l'alimentation
 - expliquer comment résoudre tous problème d'alimentation
 - expliquer comment alimenter et faire boire l'enfant malade
 - indiquer quand revenir à l'hôpital
 - donner des conseils à la mère concernant sa propre santé

CONCLUSION

- Stratégie adoptée par l'état de Côte d'Ivoire et enseignée dans les écoles de formation de base
- Difficulté dans sa mise en œuvre dans les centres de santé liée aux problèmes de ressources.

2^e PARTIE : DIRECTIVES POUR LE TRAVAIL PERSONNEL

GENERALITES SUR LA PEDIATRIE

• Intérêt du cours

Propos liminaire sur l'enseignement de la pédiatrie à l'INFAS. Le cours présente les aspects importants de la pédiatrie en Afrique subsaharienne particulièrement en Côte d'Ivoire. Il met l'accent sur les aspects pédiatriques qui feront l'objet d'un développement ultérieur durant les trois années de formation.

Objectif général

Connaître les aspects importants des soins pédiatriques

Objectifs spécifiques

1. Définir clairement les termes : pédiatrie, néonatalogie, nouveau-né, nourrisson, enfant préscolaire, enfant, adolescent
2. Identifier avec précision les principales maladies courantes de l'enfant selon le groupe d'âge
3. Citer sans se tromper tous les principaux acteurs intervenant dans les soins en pédiatrie
4. Décrire clairement le rôle de chaque acteur intervenant dans les soins de l'enfant.

ENSEIGNEMENT DIRIGE

THEME : GENERALITES SUR LA PEDIATRIE

Travail personnel de l'étudiant

- Traiter l'exercice avant de venir à l'enseignement dirigé

Exercice d'application

KT est un nourrisson de 10 mois amené en consultation de pédiatrie par ses parents accompagnés des voisins du quartier. KT présente une fièvre et émet plusieurs selles liquides depuis 24 heures. KT a été hospitalisé en néonatalogie lorsqu'il était un nouveau-né. La mère refuse de lui offrir à boire car pour elle la coutume interdit à quiconque de donner à boire à un

enfant qui fait de la diarrhée. ZO, Infirmier diplômé d'état en service depuis 3 ans, reçoit KT et ses parents en urgence et prescrit un traitement approprié suivi de conseils. La mère fonde beaucoup d'espoir sur KP, elle envisage le mettre à l'école maternelle lorsqu'il aura l'âge des enfants préscolaires. Elle sait aussi qu'il sera un bon enfant et grandira pour devenir un adolescent épanoui.

- Définir les termes: pédiatrie, néonatalogie, nouveau-né, nourrisson, enfant préscolaire, enfant, adolescent
- Identifier les acteurs en présence
- Analyser le rôle de chaque acteur
- Lister les principales maladies de l'enfant selon le groupe d'âge (nouveau-né, nourrissons, enfants, adolescents).

NOUVEAU-NE NORMAL

• Intérêt du cours

Il représente la majorité des naissances. Pour que le nouveau-né naisse normal, il faut que durant la grossesse l'agent de santé donne des conseils à la future mère. Cette dernière doit suivre ses conseils. Le module passe en revue les aspects importants de la surveillance prénatale, les caractéristiques du nouveau-né normal ainsi que les besoins à satisfaire pour qu'il ne soit pas malade.

Objectif général

Connaître le nouveau-né normal pour des soins appropriés

Objectifs spécifiques

1. Définir clairement les termes : nouveau-né normal, bilan prénatal, terme normal d'une grossesse
2. Citer sans erreur les examens du bilan prénatal recommandé en Côte d'Ivoire
3. Enumérer sans se tromper toutes les prophylaxies de la gestante
4. Décrire sans erreur les caractéristiques morphologiques et de maturations du nouveau-né normal

ENSEIGNEMENT DIRIGE

THEME : NOUVEAU-NE NORMAL

Travail personnel de l'étudiant

- Traiter les exercices avant de venir à l'enseignement dirigé

Exercices d'application

- o Situation problème n°1 page 339 du livre essentiel en pédiatrie
- o Epreuve n°1 page 43 du livre comment réussir l'épreuve de pédiatrie au diplôme d'état.

- Définir les termes : nouveau-né normal, bilan prénatal, terme normal d'une grossesse
- Lister les paramètres importants à renseigner dans le carnet de santé mère-enfant ou dans le dossier d'accouchement
- Citer les principales mesures à observer avant l'examen du nouveau-né normal.

EXAMEN DU NOUVEAU-NE EN SALLE DE NAISSANCE

• Intérêt du cours

L'examen du nouveau-né en salle de naissance est capital. Il permet d'évaluer la vitalité du nouveau-né et précise l'absence ou non d'un traumatisme obstétrical et d'une malformation évidente. Cet examen est fait juste après la naissance de l'enfant.

Objectif général

Connaître les étapes importantes de l'examen du nouveau-né normal

Objectifs spécifiques

1. Définir clairement les termes : examen du nouveau-né, traumatisme obstétrical, malformation congénitale
1. Décrire les étapes de l'examen du nouveau-né

2. Evaluer sans se tromper la vitalité du nouveau-né en utilisant le score d'APGAR
3. relever deux principaux groupes d'anomalies au terme de l'examen clinique d'un nouveau-né.

ENSEIGNEMENT DIRIGE

THEME : EXAMEN DU NOUVEAU-NE EN SALLE DE NAISSANCE

Travail personnel de l'étudiant

- Traiter l'exercice avant de venir à l'enseignement dirigé

Exercices

- o Situation problème n°11 page 350 du livre essentiel en pédiatrie
- o Epreuve n°7 page 82 du livre comment réussir l'épreuve de pédiatrie au diplôme d'état.

- Définir les termes : Salle de naissance, examen du nouveau-né, traumatisme obstétrical, malformation congénitale
- Reproduire le score d'APGAR avec tous les paramètres
- Lister les paramètres important à renseigner dans le carnet de santé mère-enfant ou dans le dossier obstétrical avant l'examen physique du nouveau-né en salle de naissance
- Citer les précautions à observer avant l'examen du nouveau-né en salle de naissance
- Rôle de soins de l'agent de santé

NOUVEAU-NE PREMATURE

• Intérêt du cours

Le nouveau-né prématuré est un nouveau-né à risque. Le risque est d'autant plus important que la prématurité est grande. Les causes de la prématurité sont variées : spontanées ou provoquées. La prise en charge du prématuré est coûteuse et exige un plateau technique performant. Le pronostic du

nouveau-né prématuré est souvent émaillé de complications. La mortalité demeure encore élevée en pratique. La prévention repose sur une meilleure gestion ou prise en charge des grossesses.

Objectif général

Connaître les aspects importants des soins pédiatriques du nouveau-né prématuré

Objectifs spécifiques

- Définir clairement les termes : nouveau-né prématuré, lanugo, vernix caseosa
- Décrire sans erreurs les caractéristiques morphologiques et de maturations du nouveau-né prématuré
- Enumérer sans erreurs les principaux problèmes du nouveau-né prématuré
- Citer les critères de sortie d'hospitalisation du nouveau-né prématuré

ENSEIGNEMENT DIRIGE

THEME : NOUVEAU-NE PREMATURE

Travail personnel de l'étudiant

- Traiter les exercices avant de venir à l'enseignement dirigé

Exercices d'application

- o Situation problème n°2 page 340 du livre essentiel en pédiatrie
- o Epreuve n°2 page 50 du livre comment réussir l'épreuve de pédiatrie au diplôme d'état.

- Définir les termes : nouveau-né prématuré, lanugo, vernix caseosa
- Classer le nouveau-né prématuré
- Lister les paramètres important à renseigner dans le carnet de santé mère-enfant ou dans le dossier d'accouchement
- Citer les principales mesures à observer avant l'examen du nouveau-né prématuré
- Enumérer les causes de la prématurité
- Citer les critères de sortie d'hospitalisation du nouveau-né prématuré
- Rôles de soins de l'agent de santé

ALLAITEMENT

• Intérêt du cours

L'allaitement représente de gold standard de l'alimentation du jeune nourrisson. Sa pratique protège l'enfant et la mère de maladies et renforce le lien entre l'enfant et sa mère. Il favorise la croissance harmonieuse et le développement cognitif optimal de l'enfant

Objectif général

Connaître les aspects importants de l'allaitement

Objectifs spécifiques

- Définir clairement les termes : allaitement, allaitement exclusif, allaitement prépondérant
- Décrire sans erreurs la physiologie de l'allaitement
- Comparer sans erreur le lait de mère et le lait de vache
- Enumérer les avantages de l'allaitement
- Citer les critères du bon positionnement aux seins, les critères d'une bonne prise de sein ; les critères d'une tétée efficace
- Citer les problèmes de l'allaitement et les ébauches de solution

ENSEIGNEMENT DIRIGE

THEME : ALLAITEMENT

Travail personnel de l'étudiant

- Traiter les exercices avant de venir à l'enseignement dirigé

Exercices d'application

Dame Nonyonflin est très inquiète et ne mange pas bien. Son enfant de 3 mois refuse de téter et dépérit. En plus du sein, l'enfant reçoit de l'eau et un biberon de lait de vache à midi. Nonyonflin a des seins engorgés de lait et douloureux avec des plaies sur le bout. Elle positionne difficilement son enfant au sein et la mise au sein n'est pas bonne de sorte que les tétées sont inefficaces. Le lait est tout blanc contrastant avec le lait jaunâtre de la 1ère semaine après accouchement.

CROISSANCE NORMALE DE L'ENFANT

• Intérêt du cours

Les parents consultent souvent pour des problèmes de croissance de leur enfant. La croissance peut être normale, insuffisante ou exagérée. Aussi la surveillance croissance est-elle un point important de la pédiatrie préventive. La croissance est à la fois quantitative et qualitative. Ces deux aspects de la croissance sont intimement liés. La surveillance régulière de la croissance permet de déceler précocement une anomalie de développement et donc d'initier précocement la prise en charge.

Objectif général

Connaître les principales étapes de la croissance normale l'enfant de 0 à 10 ans

Objectifs spécifiques

1. Définir clairement les termes : croissance somatique, maturation
2. Enumérer sans erreur les facteurs qui régissent la croissance de l'enfant
3. Citer sans erreurs les instruments utilisés en pratique pour l'appréciation de la croissance quantitative,
4. Citer les variables pour l'évaluation de la croissance qualitative
5. Décrire les étapes de la croissance quantitative et qualitative entre 0 et 10 ans

ENSEIGNEMENT DIRIGE

THEME : CROISSANCE DE L'ENFANT

1. Travail personnel de l'étudiant

- Traiter les exercices avant de venir à l'enseignement dirigé.
- Venir à l'enseignement dirigé avec un carnet de santé mère-enfant

Exercices d'application

- Définir les termes : croissance somatique, maturation
- Décrire les principaux facteurs régissant la croissance normale de l'enfant
- Décrire les moyens pour l'appréciation de la croissance quantitative (somatique) et qualitative (maturation)
- Cas pratique
 - Prendre le carnet de santé mère-enfant d'un enfant âgé de 10 à 12 mois. Répertorier les mensurations (poids, taille, périmètre crânien) prises chaque mois.
 - Comparer les poids des âges clés (Naissance, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois) aux normes établies.
 - Pour la comparaison avec les normes, il faut se référer à la page 377 du livre essentiel en pédiatrie ou 199 du livre comment réussir l'épreuve de pédiatrie au diplôme d'état)
 - Tracer la courbe de poids dans le carnet de santé-mère enfant
 - Commenter la courbe de poids sur une feuille blanche

Rôles de l'agent de santé en rapport avec la croissance de l'enfant

- Soins propres
- Soins délégués
- Soins de collaboration
- Conseils & prévention

DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR NORMAL DE L'ENFANT

• Intérêt du cours

Les parents consultent souvent pour des problèmes de retard de développement de leur enfant. Le développement psychomoteur est aussi un point important de la pédiatrie préventive. Le développement psychomoteur s'apprécie sur le plan moteur et psychique. La surveillance régulière du développement psychomoteur permet de déceler précocement une anomalie de développement et donc d'initier précocement la prise en charge.

Objectif général

Connaître les principales étapes du développement psychomoteur normal de l'enfant de 0 à 10 ans

Objectifs spécifiques

1. Définir clairement le terme de développement psychomoteur
2. Enumérer sans erreur les facteurs qui régissent le développement psychomoteur
3. Citer sans erreurs les moyens utilisés pour l'appréciation de la croissance quantitative
4. Décrire les étapes de la croissance quantitative et qualitative entre 0 et 10 ans

ENSEIGNEMENT DIRIGE

THEME : DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR (DPM)

1. Travail personnel de l'étudiant

- Traiter les exercices avant de venir à l'enseignement dirigé.
- Venir à l'enseignement dirigé un carnet de santé mère-enfant

Exercices d'application

- Définir les termes : développement psychomoteur, motricité, langage, préhension, compréhension
- Décrire les principaux facteurs régissant le DPM normal de l'enfant
- Citer les 4 moyens pour l'évaluation du DPM
- Cas pratique
 - Prendre le carnet de santé mère-enfant d'un enfant âgé de 24 à 36 mois. Répertorier les acquisitions psychomotrices notifiées dans le carnet
 - Comparer les acquisitions psychomotrices de l'enfant des âges clés (Naissance, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois) aux normes établies.
 - Pour la comparaison avec les normes, il faut se référer à la page 378 du livre essentiel en pédiatrie ou 200 du livre comment réussir l'épreuve de pédiatrie au diplôme d'état)
 - Interpréter les acquisitions de l'enfant par rapport aux normes établies (normal, retard, régression, surdoué)
 - Rôles de soins de l'agent de santé

VOMISSEMENTS DU NOURRISSON

• Intérêt du cours

Les parents consultent souvent pour des problèmes de vomissement de leur enfant. Le diagnostic positif est facile mais le diagnostic étiologique est plus difficile car les causes sont nombreuses et variées. L'enfant vomisseur est exposé en dehors de la cause à trois complications majeures : la déshydratation, la dénutrition et la fausse route pouvant entraîner le décès de l'enfant par asphyxie.

Objectif général

Connaître aspects importants des soins de l'enfant vomisseur.

Objectifs spécifiques

1. Définir clairement les termes : vomissements, déshydratation, dénutrition, fausse route, régurgitation, merycisme, vomique
2. Citer les facteurs favorisant des vomissements
3. Enumérer les principales causes de vomissements
4. citer les problèmes de l'enfant vomisseur

ENSEIGNEMENT DIRIGE

THEME : VOMISSEMENTS DU NOURRISSON

Travail personnel de l'étudiant

- Traiter les exercices avant de venir à l'enseignement dirigé

Exercices d'application

P.U est un nourrisson de 6 mois. La mère l'amène en urgence pour des vomissements répétés depuis la naissance. P.U a une dénutrition et une déshydratation. Votre interrogatoire élimine facilement une fausse route, une régurgitation, un merycisme et une vomique. Vous faite appel en urgence au médecin. Il pense à une sténose hypertrophique du pylore. Devant les vomissements répétés le médecin vous demande de lui injecter du Métopimazine (Vogalène®). Trente minutes après le soin, la mère vous rappelle car T.U présente des mouvements anormaux à type de protrusion de la langue, déviation conjuguées des yeux et une hypertonie de tous le corps.

- Définir les termes : vomissement, déshydratation, dénutrition, fausse route, une régurgitation, un merycisme et une vomique.
- Décrire les principaux facteurs favorisant des vomissements de l'enfant
- lister les causes de vomissements de l'enfant ainsi que les médicaments utilisés pour l'arrêt des médicaments
- Reproduire sur une feuille le tableau de déshydratation de l'enfant
- Rôle de soins de l'agent de santé

DIARRHEE AIGÜE ET DESHYDRATATION DU NOURRISSON

• Intérêt du cours

Les parents consultent souvent pour la diarrhée aiguë de leur enfant. Le diagnostic positif est facile mais le diagnostic étiologique est plus difficile car les causes sont variées dominées par le Rotavirus. L'enfant diarrhéique est exposé en dehors de la cause à trois complications majeures : la déshydratation, la dénutrition et la fausse route pouvant entraîner le décès de l'enfant par asphyxie.

Objectif général

Connaître aspects importants des soins de l'enfant vomisseur.

Objectifs spécifiques

1. Définir clairement les termes : diarrhée aiguë, diarrhée persistante, dysenterie, déshydratation
2. Citer les facteurs favorisant de la diarrhée
3. Enumérer les principales causes de diarrhée aiguë
4. citer les problèmes de l'enfant diarrhéique

ENSEIGNEMENT DIRIGE

THEME : DIARRHEE AIGÜE ET DESHYDRATATION DU NOURRISSON

Travail personnel de l'étudiant

- Traiter les exercices avant de venir à l'enseignement dirigé

Exercices d'application

o Situation problème n°9 page 362 du livre essentiel en pédiatrie
o Epreuve n°10 page 174 du livre comment réussir l'épreuve de pédiatrie au diplôme d'état.

- Définir les termes : diarrhée aiguë, diarrhée persistante, dysenterie, déshydratation
- Décrire les principaux facteurs favorisant de la diarrhée aiguë du nourrisson
- Citer les mécanismes de la diarrhée aiguë du nourrisson
- Enumérer les principales causes de diarrhée aiguë du nourrisson
- Citer les problèmes du nourrisson diarrhéique
- Reproduire sur une feuille le tableau de déshydratation de l'enfant
- Rôle de soins de l'agent de santé

PRISE EN CHARGE INTEGREE DES MALADIES DE L'ENFANT ET DU NOUVEAU-NE (PCIMEN)

• Intérêt du cours

La PCIMEN est une stratégie développée dans les années 2000 par l'OMS et l'UNICEF et destinée aux pays à ressources limitées pour réduire chez l'enfant la mortalité, la fréquence, la gravité des maladies et des invalidités afin de contribuer à l'amélioration de la croissance et du développement.

Objectif général

- Connaître la stratégie PCIMEN pour des soins appropriés chez l'enfant

Objectifs spécifiques

1. Définir les termes : PCIMEN, trismus, contracture
2. Citer les objectifs de la PCIMEN
3. Enumérer les maladies cibles de la PCIMEN
4. Citer les directives de la PCIMEN
5. Evaluer l'enfant malade âgé de 1semaine à 5 ans
6. Classer l'enfant malade âgé de 1semaine à 5 ans

ENSEIGNEMENT DIRIGE

THEME : PCIMEN

Travail personnel de l'étudiant

- Définir les termes : PCIMEN, maladies, décès, mortalité, morbidité
- Citer les objectifs de la PCIMEN
- Enumérer les maladies cibles de la PCIMEN
- Citer les directives de la PCIMEN
- Evaluer l'enfant malade âgé de 1semaine à 5 ans
- Classer l'enfant malade âgé de 1semaine à 5 ans
- Rôles de soins

3^e PARTIE EXERCICES

QCD

Pour toutes les affirmations suivantes, cochez la bonne réponse.

- une réponse juste : 1 point,
- une réponse fausse : -1 point
- aucune réponse : 0 point

1. Un prématuré né à 36 semaines d'aménorrhée sans signe de danger est pris en charge à l'hôpital de référence.

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

2. L'intervalle de poids de naissance normal du nouveau-né est compris entre 3000 et 3500 grammes

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

3. La fontanelle antérieure est une maladie grave chez le nouveau-né

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

4. La crise génitale du nouveau-né est provoquée par une hormone appelée ocytocine

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

5. Le méconium est le nom donné aux premières selles du nouveau-né

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

6. L'insuffisance de production du surfactant par les cellules pulmonaires est la cause de maladie des membranes hyalines du prématuré.

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

7. Le vomissement est fréquent chez le nourrisson du fait de l'immaturité de l'extrémité inférieure du cardia

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

8. La diète imposée au nourrisson lors de la diarrhée est un facteur de gravité de la diarrhée aiguë.

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

9. Le débit d'oxygène est compris entre 0,5 et 1 l/min chez le nouveau-né prématuré en détresse respiratoire

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

10. L'inhalation du liquide amniotique est la première cause de détresse respiratoire du prématuré :

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

11. La fécondation a lieu au tiers externe de la trompe de la femme

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

12. L'urée et la créatinine sanguines font partie du bilan prénatal recommandé vu au cours

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

13. Madame BN a réalisé sa prophylaxie antitétanique recommandée. Elle accouche d'un garçon dans le taxi lors de son évacuation au CHR de Korhogo. Le cordon ombilical est sectionné dans le taxi avec le coupe-ongle du chauffeur puis ligaturé avec un fil de sac de riz. Le nouveau-né risque le tétanos néonatal

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

14. Dans la stratégie PCIMEN, le code de couleur utilisé pour les enfants traités à domicile est la couleur jaune

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

15. Un enfant classer avec le code de couleur vert signifie que l'enfant est traité à l'hôpital de référence

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

16. La perte de poids physiologique de 10% du nouveau-né pendant les trois premiers jours de vie est due à l'émission du méconium et des urines.

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

17. Le nouveau-né normal a une coloration rose

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

18. La posthypophyse est le lieu de sécrétion de prolactine

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

19. Les stries plantaires sont présentes sur plus du tiers antérieur de la plante des pieds du nouveau-né prématuré.

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

20. Lorsque la gestante est économiquement faible, il faut privilégier les échographies obstétricales dans le bilan prénatal.

- ☐ A Vrai
- ☐ B Faux

21. Le spina bifida est favorisé par le non-respect de la prophylaxie contre le tétanos

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

22. On parle de retard de maturation dentaire chez un nourrisson si ce dernier n'a aucune dent dans la bouche à partir de 12 mois

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

23. Le nourrisson double sa surface corporelle à 3 mois

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

24. La dose de vitamine K1 administrée en intramusculaire au nouveau-né normal est de 1 mg

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

25. Le placenta prævia recouvrant hémorragique avec souffrance fœtale aiguë est une cause spontanée de prématurité.

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

26. Le maintien de la tête est une nouvelle performance psychomotrice attendue chez le nourrisson de 6 mois.

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

27. La succion du mamelon par l'enfant déclenche un influx nerveux qui stimule au niveau de l'antéhypophyse la sécrétion de l'ocytocine.

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

28. La mère allaitante boit en plus de l'eau contenu dans les aliments au maximum 1 litre d'eau par jour

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

29. Est qualifié de prématuré tous nouveau-né dont le poids de naissance est en dessous de 2500g

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

Cocher la bonne affirmation

30. Un nouveau-né eutrophique a un poids de naissance compris entre 2500 et 4000 grammes

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

31. Chez le nouveau-né normal, la fontanelle postérieure est plus large que l'antérieure

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

32. La crise génitale du nouveau-né est provoquée par l'hormone ocytocine

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

33. Les premières selles du nouveau-né s'appellent méconium

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

34. La maladie des membranes hyalines du prématuré est provoquée par l'insuffisance de sécrétion pulmonaire du surfactant

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

35. Le manque de cohésion familiale favorise les vomissements du nourrisson.

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

36. La diète imposée au nourrisson par les parents favorise la déshydratation au cours de la diarrhée

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

37. Chez le nouveau-né prématuré en détresse respiratoire le débit d'oxygène est compris entre 0,5 et 1 l/min :

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

38. L'infection est la première cause de détresse respiratoire du prématuré

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

39. La fécondation a lieu au tiers interne de la trompe de la femme

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

40. L'urée et la créatinine sanguines font partie du bilan prénatal recommandé vu au cours

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

41. Madame CB a réalisé durant sa grossesse une dose de vaccin antitétanique recommandé une semaine avant l'accouchement de sa fille. Le nouveau-né risque le tétanos néonatal

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

42. Dans la stratégie PCIMEN, le code de couleur utilisé pour les enfants traités à domicile est la couleur jaune.

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

Cocher la bonne affirmation

43. Un enfant classer avec le code de couleur rose signifie que l'enfant est traité à l'hôpital de référence

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

44. Nouveau-né NV, Jour 6 de vie. Il a un tétanos néonatal avec un score pronostic de Dakar à 2. Le tétanos de NV est modéré

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

45. Une femme enceinte informe la sage-femme traitante que son argent ne suffit pas pour réaliser la totalité du bilan prénatal. Dans cette situation, le l'échographie est prioritaire sur le bilan biologique.

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

46. Le spina bifida du nouveau-né est favorisé par le non-respect par la mère de la prophylaxie contre l'anémie durant la grossesse

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

47. On parle de retard de maturation dentaire chez un nourrisson si ce dernier n'a aucune dent dans la bouche à partir de 15 mois

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

48. Le surfactant est produit par les pneumocytes II du poumon du nouveau-né

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

49. Pour éviter la survenue de la maladie hémorragique du nouveau-né, l'agent de santé administre au nouveau-né de la vitamine K1 par voie musculaire.

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

Cocher la bonne affirmation

50. Le débit d'oxygène du nouveau-né prématuré pour prévenir une lésion grave de la rétine est comprise entre 0,5 et 1 litre par minute.

- ☐ A Vrai
☐ B Faux

QCM

Pour toutes les affirmations suivantes, cochez la bonne réponse.

- une réponse juste : 1 point,
- une réponse fausse : 0 point
- aucune réponse : 0 point

51. J'accompagne en radiologie pour sa radiographie du thorax un nouveau-né malade. Cet acte de soins figure dans mes rôles :

- ☐ A Propres
☐ B Délégués
☐ C Collaboration
☐ D Conseils et prévention

52. Les signes suivants témoignent d'une immaturité du nouveau-né sauf un. Quel est ce signe ?

- ☐ A fins poils au dos
☐ B enduit blanchâtre sur le corps
☐ C nodule mammaire <4 mm
☐ D lobule de l'oreille présent

53. La fréquence cardiaque normale du nouveau-né est comprise entre

- ☐ A 100 et 160 battements par minute
☐ B 160 et 190 battements par minute
☐ C 80 et 100 battements par minute
☐ D 90 et 120 battements par minute

54. CV monte l'escalier en se tenant à la rampe. Il tape le pied dans le ballon et imite les tâches ménagères de l'adulte. CV a les performances psychomotrices d'un enfant de :

- ☐ A 12 mois
☐ B 16 mois
☐ C 15 mois
☐ D 18 mois

55. BN, sexe féminin, copie un carré. Fait de la bicyclette sans roue latérale et connaît les couleurs et raconte des petites histoires. BN a les performances psychomotrices d'un enfant de

- ☐ A 3 ans
☐ B 4 ans
☐ C 6 ans
☐ D 2 ans

56. CF monte l'escalier en se tenant à la rampe. Il tape le pied dans le ballon et imite les tâches ménagères de l'adulte. CF a les performances psychomotrices d'un enfant de :

- ☐ A 12 mois
☐ B 16 mois
☐ C 15 mois
☐ D 18 mois

57. Le nourrisson CV émet les sons « da-da-da » et se tient debout avec appui. Je conclus que CV a les acquisitions psychomotrices d'un enfant de

- ☐ A 12 mois
☐ B 9 mois
☐ C 8 mois
☐ D 6 mois

58. Je reçois un nourrisson qui pèse 9 kg. Il est né à 3 kg et correctement alimenté depuis la naissance. Ce nourrisson est âgé de :

- ☐ A 16 mois
- ☐ B 12 mois
- ☐ C 16 mois
- ☐ D 10 mois

59. YK, 5 min de vie, bleu de partout, tout flasque, ne respire pas, ne pleure pas, pouls à 100 battements par minute. Le score de vitalité à 5 minute de vie est :

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 4

60. Parmi les actes de soins au nouveau-né suivants, un seul fait partie du rôle délégué de l'agent de santé. Quel est cet acte ?

- ☐ A Placer le bébé dans la couveuse
- ☐ B Prendre la température du bébé
- ☐ C Accompagner le bébé en diététique
- ☐ D Administrer la vitamine K1 en IM

61. Parmi les affections congénitales suivantes cochez la seule qui correspond à un excès de Kératinisation de la peau :

- ☐ A Spina bifida congénitale
- ☐ B Anencéphalie congénitale
- ☐ C Omphalocèle congénitale
- ☐ D Ichtyose congénitale

62. Les bilans sanguins suivants vu au cours sont recommandés pendant la grossesse sauf un. Quel est ce bilan ?

- ☐ A Sérologie hépatite B
- ☐ B Sérologie syphilis
- ☐ C Sérologie rubéole
- ☐ D Sérologie VIH

63. JK est né à terme avec une surface corporelle de 0,25 m². Il est correctement nourri. A 36 mois, la surface corporelle de JK est :

- ☐ A 0,44m²
- ☐ B 0,62 m²
- ☐ C 0,40 m²
- ☐ D 0,50 m²

64. L'âge gestationnel du moyen prématuré est

- ☐ A]33-35[semaines d'aménorrhée
- ☐ B]33-35[semaines d'aménorrhée
- ☐ C]33-35[semaines d'aménorrhée
- ☐ D]33-35[semaines d'aménorrhée

65. KJ est âgé de 9 ans. Il a une croissance normale. Le poids idéal théorique de KJ est

- ☐ A 24 kg
- ☐ B 20 kg
- ☐ C 22 kg
- ☐ D 26 kg

66. A 6 mois, le nourrisson :

- ☐ A Porte l'objet à la bouche
- ☐ B Fait les quatre pattes
- ☐ C Fait bravo et au revoir
- ☐ D Saisie l'objet entre pouce et index

67. Chez le nouveau-né grand prématuré, la détresse respiratoire est surtout due à :

- ☐ A Infection pulmonaire bactérienne
- ☐ B Maladie des membranes hyalines
- ☐ C Retard de résorption pulmonaire
- ☐ D Inhalation du liquide amniotique

68. La fréquence respiratoire normale du nouveau-né est comprise entre

- ☐ A 40 et 60 cycles par minute
- ☐ B 40 et 70 cycles par minute
- ☐ C 30 et 65 cycles par minute
- ☐ D 60 et 85 cycles par minute

69. Le poids théorique d'un enfant de 6 ans correctement nourri depuis la naissance est de :

- ☐ A 16 kg
- ☐ B 18 kg
- ☐ C 20 kg
- ☐ D 22 kg

70. DF, 1 jours de vie. Il respire difficile et le médecin sollicite l'agent de santé pour l'accompagner en radiologie pour la réalisation d'une radiographie du thorax. Cet acte de soins rentre dans mes rôles

- ☐ A Propres
- ☐ B Conseils et prévention
- ☐ C Délégués
- ☐ D Collaboration

71. Dans la stratégie PCIMEN, pour classer l'enfant les couleurs utilisées sont

- ☐ A Rose, vert, orange
- ☐ B Rose, jaune, vert
- ☐ C Rose, jaune, rouge
- ☐ D Rose, vert, rouge

72. DF, 1 jours de vie. Son examen est normal. Je lui administre de la vitamine K1 en intra musculaire pour prévenir la maladie hémorragique du nouveau-né. Cet acte de soins rentre dans mes rôles

- ☐ A Propres
- ☐ B Conseils et prévention
- ☐ C Délégués
- ☐ D Collaboration

73. La fontanelle postérieure de l'enfant se ferme à

- ☐ A 18 mois
- ☐ B 3 mois
- ☐ C 5 mois
- ☐ D 6 mois

74. On parle de retard d'éruption dentaire à partir de

- ☐ A 12 mois
- ☐ B 18 mois
- ☐ C 15 mois
- ☐ D 16 mois

75. La forme de la fontanelle antérieure de l'enfant est :

- ☐ A Rectangle
- ☐ B Carré
- ☐ C Losange
- ☐ D Cercle

76. La fontanelle antérieure de l'enfant est une :

- ☐ A zone anatomique au niveau de la tête
- ☐ B maladie sous la peau de la tête
- ☐ C maladie au milieu de la tête
- ☐ D Aucune des trois propositions

77. Le grand prématuré a un âge gestationnel compris entre :

- ☐ A [28-32] semaines d'aménorrhée
- ☐ B]28-32[semaines d'aménorrhée
- ☐ C [28-33[semaines d'aménorrhée
- ☐ D]28-33[semaine d'aménorrhée

78. La période de l'embryogenèse qui suit la nidation s'étend de

- ☐ A Jour 8 à Jour 60
- ☐ B Jour 8 à Jour 70
- ☐ C Jour 8 à Jour 80
- ☐ D Jour 8 à Jour 90

79. Les facteurs suivants régissent la croissance de l'enfant sauf un. Quel est ce facteur ?

- ☐ A Hérité
- ☐ B Hormone
- ☐ C Hygiène
- ☐ D Alimentation

80. Un enfant qui émet au moins trois selles molles par 24 heures depuis 15 jours présente une :

- ☐ A diarrhée aiguë
- ☐ B diarrhée persistante
- ☐ C diarrhée chronique
- ☐ D Diarrhée subaiguë

81. La maturation correspond à

- ☐ A augmentation du volume des tissus
- ☐ B augmentation de la taille des tissus
- ☐ C perfectionnement des tissus
- ☐ D Aucune des trois propositions

82. Pour apprécier la maturation l'agent de santé utilise

- ☐ A Poids et taille
- ☐ B Poids et périmètre brachial
- ☐ C Poids et périmètre crânien
- ☐ D Eruption dents et fontanelle

83. Le nouveau-né de sexe masculin normal a :

- ☐ A nodule mammaire < 3 mm
- ☐ B température rectale 35°5 Celsius
- ☐ C fréquence respiratoire 70 cycles/min
- ☐ D Fréquence cardiaque 120 battements/min

84. L'analyse de la courbe de poids d'un enfant de 6 mois allaité exclusivement depuis la naissance montre :

- ☐ A ascension avec risque d'obésité
- ☐ B régression avec risque d'obésité
- ☐ C stagnation avec risque d'obésité
- ☐ D aucune des trois propositions

85. A l'âge de 7 mois, le nourrisson

- ☐ A Attrape ses pieds
- ☐ B Tire un objet par la ficelle
- ☐ C A peur de l'étranger
- ☐ D émet les sons (da-da-da..)

86. Pour traiter le syndrome extrapyramidal provoqué par l'antiémétique, j'administre

- ☐ A Diazépam
- ☐ B Amoxicilline
- ☐ C Ceftriaxone
- ☐ D Paracétamol

87. A l'âge de 9 mois, l'enfant est capable de :

- ☐ A marcher avec appui
- ☐ B dire papa et maman
- ☐ C faire bravo et au revoir
- ☐ D pointer du doigt

88. A l'âge de 18 mois, l'enfant est capable de

- ☐ A monter et descendre un escalier seul
- ☐ B imiter les tâches ménagères de l'adulte
- ☐ C reconnaître les différentes couleurs
- ☐ D copier un carré sur un support

89. Un enfant de 3 ans est capable de

- ☐ A faire de la bicyclette sans roue latérale
- ☐ B monter et descendre un escalier
- ☐ C dessiner un triangle
- ☐ D reconnaître sa droite et sa gauche

90. Le trait distinctif du groupe d'âge nouveau-né est :

- ☐ A la fragilité
- ☐ B la souplesse
- ☐ C l'innocence
- ☐ D la mollesse

91. KL est âgé de 5 mois et présente une diarrhée aiguë avec signes évidents de déshydrations.

- ☐ A KL boit normalement
- ☐ D KL a les yeux très enfoncés
- ☐ C KL est agité
- ☐ D KL a les lèvres très sèches

92. Les causes suivantes sont responsables de vomissements aigus sauf une. Quelle est cette cause ?

- ☐ A atrésie de l'œsophage
- ☐ B Occlusion intestinale
- ☐ C Sténose hypertrophique du pylore
- ☐ D erreur diététique

93. Pour décider de la sortie d'hospitalisation du prématuré, je m'assure que la fréquence cardiaque est comprise entre

- ☐ A 120 et 100 battements/minutes
- ☐ B 80 et 100 battements/minutes
- ☐ C 90 et 100 battements/minutes
- ☐ D 70 et 100 battements/minutes

94. En 2016, la population ivoirienne était estimée à 23 740 424 Habitants. La proportion d'enfant de 0-14 ans était estimée à :

- ☐ A 36%
- ☐ B 38%
- ☐ C 37%
- ☐ D 35%

95. La principale complication métabolique du nouveau-né prématuré est

- ☐ A hypoglycémie
- ☐ B hyponatrémie
- ☐ C hypomnésie
- ☐ D hypocalcémie

96. Le moyen prématuré a un âge gestationnel compris entre :

- ☐ A [33-35] semaines d'aménorrhée
- ☐ B]33-35[semaines d'aménorrhée
- ☐ C [33-35[semaines d'aménorrhée
- ☐ D]33-35[semaines d'aménorrhée

97. LM est âgé de 12 mois et pèse 9 kilogrammes. Son poids de naissance était de :

- ☐ A 3250g
- ☐ B 3150g
- ☐ C 3000g
- ☐ D 3100g

98. En Côte d'Ivoire, la principale cause de d'hospitalisation et décès du nouveau-né est

- ☐ A infection néonatale
- ☐ B paludisme néonatal
- ☐ C anémie néonatale
- ☐ D ictère néonatal

99. CL est âgé de 4 ans et mesure 100 cm. Il n'a eu aucun problème de croissance. Sa taille de naissance était de

- ☐ A 51 cm
- ☐ B 50 cm
- ☐ C 49 cm
- ☐ D 48 cm

100. Le nouveau-né normal a :

- ☐ A un lobule de l'oreille ourlée
- ☐ B un poids de 2400g
- ☐ C une fontanelle bombée
- ☐ D un nodule mammaire de 2 mm

101. Le mécanisme de la diarrhée aiguë à Shiguelle est le mécanisme

- ☐ A Invasif
- ☐ B Toxinique
- ☐ C mixte (Invasif + toxinique)
- ☐ D aucune des trois propositions

102. Le principal agent pathogène de la diarrhée aiguë bactérienne est

- ☐ A Shiguelle
- ☐ B Escherichia coli
- ☐ C Salmonelle
- ☐ D Staphylocoque

103. La capacité d'absorption et de sécrétion du tube digestif est maintenue au cours de la diarrhée aiguë dans

- ☐ A 25-35%
- ☐ B 35-40%
- ☐ C 40-45%
- ☐ D 50-70%

104. La prise en charge intégrée des maladies de l'enfant et du nouveau-né a pour but de

- ☐ A Améliorer la compétence du personnel
- ☐ B Améliorer le confort de l'enfant
- ☐ C Améliorer le confort des parents
- ☐ D Améliorer le cadre de vie communautaire

105. L'adolescent est un enfant dont l'âge est compris entre

- ☐ A 13 et 17 ans
- ☐ B 13 et 18 ans
- ☐ C 13 et 19 ans
- ☐ D 13 et 20 ans

106. En Côte d'Ivoire, les prophylaxies recommandées à la femme enceinte sont

- ☐ A paludisme + anémie + tétanos
- ☐ B syphilis+ toxoplasmose + rubéole
- ☐ C VIH+ infection génitale+ méningite
- ☐ D Hépatite + coqueluche+ diphtérie

107. FG, 1 jours de vie, il pèse plus de 1500g. Son examen est normal. Je lui administre 1mg de vitamine K1 en intra musculaire pour prévenir la maladie hémorragique du nouveau-né. Cet acte de soins rentre dans mes rôles

- ☐ A propres
- ☐ B conseils et prévention
- ☐ C délégués
- ☐ D collaboration

108. A 6 mois, le nourrisson :

- ☐ A saisie l'objet entre pouce et index
- ☐ B fait les quatre pattes
- ☐ C fait bravo et au revoir
- ☐ D porte l'objet à la bouche

109. Le poids théorique d'un enfant de 6 ans correctement nourri depuis la naissance est de :

- ☐ A 16 kg
- ☐ B 18 kg
- ☐ C 20 kg
- ☐ D 22 kg

110. Nouveau-né CB vient de naître et respire difficile. Le médecin sollicite l'agent de santé pour l'accompagner en radiologie pour une radiographie du thorax. Cet acte de soins rentre dans mes rôles

- ☐ A propres
- ☐ B conseils et prévention
- ☐ C délégués
- ☐ D collaboration

111. Dans la stratégie PCIMEN, pour classer l'enfant les couleurs utilisées sont

- A** Rose, vert, orange
- B** Rose, jaune, vert
- C** Rose, jaune, rouge
- D** Rose, vert, rouge

112. SP est né à terme avec une surface corporelle de $0,20\text{m}^2$. Il est correctement nourri. A 36 mois, la surface corporelle de SP est :

- A** $0,40\text{m}^2$
- B** $0,60\text{m}^2$
- C** $0,30\text{m}^2$
- D** $0,50\text{m}^2$

113. YK a 4 ans. Sa croissance est normale et mesure 104 centimètres. Je déduis que la taille de naissance de YK était de :

- A** 51 cm
- B** 52 cm
- C** 53 cm
- D** 50 cm

114. Les bilans sanguins suivants vu au cours sont recommandés pendant la grossesse sauf un. Quel est ce bilan ?

- A** Sérologie de la toxoplasmose
- B** Sérologie de la syphilis
- C** Sérologie de la rubéole
- D** Sérologie de l'hépatite B